العام الجامعي
2026 / 2027

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون

مذكرات ومراجعات تفاعلية معتمدة

• مراجعة ليلة الامتحان •

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

- تأصيل تحليلي
- تطبيقات قضائية
- صياغة أكاديمية

القضايا الفقهية المعاصرة

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الأولى

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478

القضايا الفقهية المعاصرة

ثلاث قضايا فقهية طبية كبرى

محتويات المقرر

القضية الأولى: التجارب الطبية

القضية الثانية: تأجير الأرحام

القضية الثالثة: موت الدماغ

القضية الأولى: التجارب الطبية المعاصرة وحرمة جسد الإنسان

١ المبحث الأول: مفهوم التجارب الطبية وأنواعها وتاريخها

٢ المبحث الثاني: الحكم الشرعي للتجارب الطبية على الإنسان

٣ المبحث الثالث: القيود الواردة على إجراء التجارب الطبية على البشر

٤ المبحث الرابع: المسؤولية عن إجراء التجارب الطبية

تُعالج هذه القضية سؤالًا محوريًا: **هل يجوز شرعًا إخضاع جسد الإنسان للتجارب الطبية؟** والإجابة ليست نعم أو لا مطلقة، بل تتفرع حسب نوع التجربة، وحالة الخاضع لها (حي، ميت، جنين)، والقيود المحيطة بها.

المبحث الأول: مفهوم التجارب الطبية وأنواعها وتاريخها

١ مفهوم التجارب الطبية

لغويًا: التجربة مأخوذة من الفعل «جَرَّبَ»، أي: اختبره، ورجل مُجَرِّبٌ: أي قد عرف الأمور وجَرَّبَهَا، وهي من المصادر المجموعة.

المعنى الاصطلاحي – ثلاثة تعريفات

1. **التعريف الأول:** هي الأعمال العلمية أو الفنية الطبية التي تعمل **دون ضرورة تمليها حالة المرضى ذاتهم**، لإشباع شهوة علمية، أو لخدمة الطب والإنسانية.
2. **التعريف الثاني:** هي التجارب العلمية أو الفنية التي يقوم الطبيب بإجرائها على مريضه.

MARA 01105405478

3 **التعريف الثالث:** هي استخدام وسائل أو طرق جديدة على إنسان سليم أو مريض، بغرض **البحث العلمي**، وفقًا للأصول العلمية، دون أن يكون في حاجة إليها.

✅ **التعريف الجامع:** التجربة الطبية: كل عمل علمي أو فني طبي يباشره طبيب أو فريق بحثي على إنسان سليم أو مريض، باستخدام وسائل أو طرق جديدة، بغرض البحث العلمي وتطوير المعرفة الطبية، وفقًا للأصول العلمية المتعارف عليها، دون أن تمليه ضرورة علاجية مباشرة لحالة الخاضع لها، مع تمييزها عن التدخل العلاجي الذي يستهدف تحسين الحالة الصحية للمريض مباشرة.

↩ **التمييز بين التجربة الطبية والتدخل العلاجي:** التجارب الطبية تختلف عن التدخل العلاجي؛ حيث إن الأخير **عمل مشروع بالاتفاق**، ويتمثل في مجموعة من الأعمال الفنية والطبية التي يباشرها الطبيب **لمصلحة المريض** لغرض تحسين حالته الصحية، أما التجربة فتتم **دون ضرورة تمليها حالة المريض** بل لإشباع شهوة علمية أو تطوير الطب.

٢ أنواع التجارب الطبية

تتنوع التجارب الطبية إلى **نوعين رئيسين** تبعًا للغرض:

❖ **النوع الأول: التجارب العلاجية** هي التجارب التي يباشرها الطبيب بقصد **علاج المريض** باستخدام وسائل حديثة في الحالات المرضية التي تفتقد إلى دواء معروف كفيل بتحقيق الشفاء، والغرض الأساسي: محاولة إيجاد علاج للمريض عن طريق تجربة العديد من الأدوية والعلاجات التي يرى الطبيب أنها تُجْدِي نفعًا، مع إمكانية الاستفادة من المعارف المكتسبة منها وتعميم الفائدة إلى غيره من المرضى.

♟ **النوع الثاني: التجارب العلمية (غير العلاجية)** هي التجارب التي يخضع بمقتضاها الكائن البشري لطرق وأساليب **دون ضرورة تمليها حالته**، ويطلق عليها أيضًا: كُلُّ بحث منهجي يهدف إلى تنمية المعرفة على وجه العموم، وقيل: هي أعمال فنية وعلمية يباشرها الطبيب على جسم المريض بغرض **اكتساب معارف جديدة** بخصوص الوقاية من الأمراض، أو المعالجة الوقائية، أو العلاج.

↩ **الفارق بين النوعين:** يرى البعض أن التفرقة بينهما تبدو غير واضحة المعالم؛ لأن العلاج قد يكون عقدًا (كحالة اتفاق المريض مع طبيب خاص) أو من أعمال المساعدة (كحالة المستشفيات العامة)، أما التجارب العلمية فتسمح للباحث بالتحقق من صحة فرض معين،

وهي عمل من أعمال الإيثار، دافعه مصلحة الطب ذاته بهدف تطوير العلم والمعرفة وليس مصلحة من تُجرى عليه. وبناءً على ذلك فالفارق يَكْمُنُ في **الهدف** : فالتجربة العلاجية هدفها إيجاد أفضل طرق العلاج المتاحة للمريض وتعميم الفائدة، أما التجربة العلمية فتهدف إلى كشف طبي جديد يُجْرَى على مجموعة من الأفراد (أصحاء أو مرضى) ليست لهم مصلحة شخصية ومباشرة في إجراء التجربة.

٣ تاريخ التجارب الطبية

لا تعتبر التجارب الطبية من نوازل العصر الحديث؛ فقد صَرَّحَ الطبيب **أبقراط** بقوله: «*الطب قياس وتجربة*».

التجارب في الحضارة الإسلامية – ثلاثة نماذج

1. **الرازي:** أَجْرَى نوعين من التجارب: على الإنسان (حيث قسّم مرضى السرسام إلى مجموعتين، عالج إحداهما بالفصد وترك الأخرى، وراقب النتائج)، وعلى الحيوان (حيث جَرَّبَ تأثير الزئبق على القرود).
2. **ابن سينا:** قام بتجربة وضع الثلج على الرأس لمنع مادةٍ تَصَوَّرَ أنها تريد النزول إلى حجاب الرأس، فنجحت، كما أجرى تجربةً على امرأة مصابة بداء السل بأمرها بتناول دواء «الجلنجبين السكري» فَشُفِيَتْ.
3. **ابن أصيبعة – في عيون الأنباء في طبقات الأطباء:** عقد فصلاً عن أهمية التجارب، مؤكدًا أن الطب مبني على الملاحظة والتجربة، وَرَدَّ على من ادعى أن الطب يُؤْخَذُ من طريق الإلهام والوحي فقط.

دلالة الأمثلة التاريخية: فهذه الأمثلة التاريخية ليست مجرد سرد، بل **تثبت أن التجارب الطبية لها جذور في الحضارة الإسلامية**، وأن الفقهاء لم يواجهوا مسألة مستحدثة كليًا، بل مسألة لها سوابق يمكن القياس عليها.

التجارب في العصر الحديث

أيقن الأطباء أن التجارب على الحيوانات لم تعد كافية؛ لأن تأثير الدواء يختلف من الإنسان عنه في الحيوان، فبات ضروريًا اللجوء إلى الإنسان، إلا أنه في البدايات لم يتوفر ضوابط تحمي الخاضع للتجربة، وإنما كان الاعتماد على ضمير الباحث، مما أدى إلى عواقب سيئة.

أ أبرز الوقائع التاريخية

1. **١٩٤٦م – الحرب العالمية الثانية:** قام **٢٣ طبيبًا ألمانيًا** بتجارب عنيفة على آلاف الأسرى والسجناء، مما سبب موت معظمهم وإصابة العديد بإعاقات مستديمة.
2. **تجارب توسكيجي (١٩٣٢م):** بتمويل حكومي أمريكي، أُجريت تجارب على **٣٩٩ مريضًا بالزهري** من الزنوج الفقراء في ألاباما، استمرت **٤٠ عامًا** رغم ظهور علاج فعال، وأدت إلى مقتل ٢٨ مريضًا ووفاة ١٠٠ آخرين وإصابة ٤٠ سيدة وولادة ١٩ طفلًا مصابًا.
3. **تجارب جواتيمالا:** بعد اكتشاف علاج الزهري، نُقلت العدوى عنوةً إلى المرضى العقليين والجنود، حتى وصل المصابون إلى **١٥٠٠ شخص**، تُرِكَ ثلثهم بدون علاج.
4. **جزر مارشال (١٩٥٢م):** أُجريت دراسة على سكان الجزيرة بعد تعرضهم لإشعاع نووي، دون إبلاغهم، وخلال ١٠ سنوات زادت حالات الإجهاض وسرطان الغدة الدرقية، وبحلول ١٩٧٤م أُصيب **ثلث السكان بأورام سرطانية**.

⚠ **دلالة ذكر هذه الوقائع:** وذكر هذه الوقائع ليس للتأثير العاطفي، بل لأنها **السبب المباشر** في نشوء المواثيق الدولية المنظمة للتجارب (هلسنكي، جينيف، نورمبرغ)، وهي التي دفعت الفقهاء المعاصرين لوضع ضوابط شرعية صارمة، فكل قيد سيأتي لاحقًا في المبحث الثالث هو **رد فعل على واحدة من هذه الجرائم**.

ب المواثيق الدولية المنظمة

1. **إعلان هلسنكي الأول:** وَضَعَ قواعد يسترشد بها الأطباء في إجراء التجارب على الإنسان.
2. **اتفاقية جينيف (١٩٤٦م):** نصت على تحريم: **القتل المتعمد** أو الإجهاز على المرضى والجرحى، **التعذيب** أو المعاملة اللا إنسانية، **إخضاع المرضى والجرحى** لاختبارات بيولوجية أو تجارب طبية أو علمية، أو التسبب المقصود في عدوانهم بأمراض أو بتر أي عضو.
3. **محكمة نورمبرغ (١٩٤٩م):** أرست المبادئ القانونية للتجارب على الإنسان عند محاكمة الأطباء النازيين.

ج الإسلام والطب

اتسم الإسلام بأنه دين عام وشامل، لا يقف حجر عثرة أمام التقدم، بل يقف خلف كل تطور يحقق مصلحة الإنسان، ولعل المجال الطبي من أهم المجالات نظرًا لتعلقه بحياة الإنسان،

MIARA 01-10540578

إذ من المقرر أن **حفظ النفس من الكليات الخمس**.

يقول **النبي** ﷺ: « «تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنَزِّلْ دَاءً، إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً، إِلَّا الْمَوْتَ وَالْهَرَمَ» ».

✅ **الخلاصة:** غاية ما في الأمر أن الإسلام اشترط في الدواء أن **لا يكون محرمًا**، وأن لا يكون في إجراء التجارب اعتداء على ثوابت الشريعة ومخالفة نصوصها القاطعة، واعتداء على خصوصيات المرضى وهتك أسرارهم. فالإسلام لم يرفض الطب التجريبي، بل وضع له إطارًا أخلاقيًا، فـ **الأصل الإباحة، والقيود استثناءات تحمي كرامة الإنسان** ، وهذه القاعدة ستحكم كل الأحكام اللاحقة.

المبحث الثاني: الحكم الشرعي للتجارب الطبية على الإنسان

بعد أن فهمنا ما هي التجربة الطبية وأنواعها وتاريخها، ننتقل الآن للسؤال الفقهي المركزي: ما حكم إجرائها على الإنسان؟ والإجابة تتفرع حسب حالة الشخص: **حي، ميت، أو بويضة ملقحة**.

التجارب الطبية ضرورة من ضرورات التقدم العلمي، إلا أنها تعرضت للنقد الشديد بسبب الجرائم التي ارتكبت باسم الطب، والتجارب على البشر تختلف في مدى خطورتها، فتقسم إلى:

❌ **القسم الأول: التجارب المميتة** وهي المؤدية حتمًا إلى هلاك الخاضع لها أو غلبة الظن بهلاكه، وشروطها:

- أن يكون الموت النتيجة الطبيعية في حال عدم نجاح التجربة.
- أن تؤدي إلى الإصابة بأمراض تؤدي حتمًا للوفاة.
- أن يغلب على ظن القائم بالتجربة موت الخاضع لها.

وهذا النوع يتم غالبًا دون علم من تُجْرَى عليهم، ودون اتخاذ تدابير وقائية، وغالبًا على المساجين وأسرى الحرب والفقراء، ومن أمثلته: التجارب الحيوية (الفيروسية والبكتيرية)، والتجارب الدوائية لمعرفة التأثيرات الجانبية، والتجارب لمعرفة أضرار أسلحة أو مواد خطرة.

⚠️ **القسم الثاني: التجارب المؤدية لأضرار** وهي التي تُلْحِقُ أضرارًا **جسدية أو عقلية أو معنوية** بمن تُجْرَى عليه، والتاريخ حافل بوقائعها (تجارب توسكيجي، جواتيمالا، جزر مارشال — سبق تفصيلها).

١ المطلب الأول: حكم إجراء التجارب العلاجية على الأحياء

يقصد بالأحياء: الأشخاص على قيد الحياة (مرضى أو أصحاء متطوعين)، وقد اختلف الرأي على قولين:

أولًا: سبب الخلاف

١ التعارض بين **مصلحة البشرية** في الوصول إلى علاج جديد، وبين **الحق المقرر للإنسان على جسده** وما له من حرمة.

٢ عدم وجود النص الصريح الحاسم، مما أوجب إعمال قواعد المصالح والمفاسد: فمن رَجَّحَ مصلحة المجتمع أجاز، ومن نظر إلى حرمة الفرد منع.

توضيح: فهذا الخلاف ليس خلافًا في النصوص، بل في **الموازنة بين مقصدين شرعيين**: حفظ النفس (الذي يتطلب التداوي والتجارب) وحرمة الجسد (الذي يمنع الاعتداء عليه)، وكل فريق رجح مقصدًا على الآخر.

ثانيًا: أدلة القول الأول (الجواز)

الدليل الأول – قصة الخضر وقتل الغلام: قال تعالى: «فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا». وجه الدلالة: دلت الآية على جواز قتل النفس إذا كان محققًا للمصلحة، والمصلحة التي أرادها الخضر أشار إليها القرآن: «وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا»، وهذه مصلحة خاصة، فمن باب أولى يجوز إذا كان محققًا لمصلحة عامة للمرضى.

الدليل الثاني – آية إحياء النفس: قال تعالى: «مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا». وجه الدلالة: أمر الله بإحياء النفوس ومدح من كان سببًا في إحيائها. ويتفق العقلاء على أن المرض أحد أسباب هلاك النفوس، والأدوية تنقذ الحياة، ولا يتوصل إليها إلا بالتجارب، فتكون مشروعة.

الدليل الثالث – آية التهلكة: قال تعالى: «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» . وجه الدلالة:

نهى الله عن إلقاء النفس في مواطن الهلكة، فدل على استحباب التداوي؛ إذ كلمة التهلكة عامة تشمل ترك التداوي، ولا شك أن ترك المرضى بدون علاج يؤدي إلى تضاؤل الثروة البشرية، وبما أن التجارب تسهم في التقليل من عدد المرضى كان إجراؤها مشروعًا.

الدليل الرابع – حديث أنس في تلقيح النخل: ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ مَرَّ بقوم يلقحون النخل، فقال: «لو لم تفعلوا لصلح» ، قال: فخرج شيصًا، فَمَرَّ بهم فقال: «ما لنخلكم؟» فقالوا: قلت كذا وكذا، قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم» . وجه الدلالة:

دل الحديث على مشروعية التجارب وصولًا إلى النتائج الصحيحة.

الدليل الخامس – عموم أحاديث التداوي: أ: ما رواه أبو الدرداء رضي الله عنه: «إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ» . ب: ما رواه أسامة بن شريك رضي الله عنه: «تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً، إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً، إِلَّا الْمَوْتَ، وَالْهَرَمَ» . وجه الدلالة: تضمن الحديثان إثبات الأسباب والمسببات، والتجارب أحد مقومات العلاج ما لم تعتمد على محرم، وفيهما تصريح باشتراط **حل الدواء** .

الدليل السادس – فعل عروة بن الزبير: ما روي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم قال: رأيت عروة أصابه الآكلة فقطع رجله من الركبة. وجه الدلالة: أتلف عروة عضوًا حفاظًا على باقي الأعضاء، أي من باب **إتلاف الجزء لاستبقاء الكل** ، والتجارب تتم فيها التضحية بعدد محدود بهدف علاج باقي المرضى.

الدليل السابع – ضرورة التقدم العلمي: إن التجارب الطبية ضرورية لتقدم العلوم الطبية، وبدونها يقف الطب عاجزًا، ومما يدعم ذلك أن بعض الأمراض تصيب الإنسان ولا تصيب الحيوان والعكس، وقد أثبت العلم اختلاف تأثير الأدوية في الإنسان عنه في الحيوان، ولا يمكن القول بأن المخاطر تؤدي إلى عدم المشروعية؛ لأن العمل الطبي طبيعته تتضمن مخاطر.

الدليل الثامن – الاستثناء للمصلحة: إن الأصل أن التحريم يمتد إلى الكافة، إلا أن الشارع أورد استثناءات حالة توافر مصلحة الجماعة أو الأفراد، فالطبيب الذي يجرح مريضًا بقصد علاجه يؤدي واجبًا مباحًا، أما إذا كان الجرح بقصد القتل ففعله جريمة، وبالتالي فالتجارب وإن كانت ممنوعة أصلًا لمساسها بجسد الإنسان، إلا أن التحريم ارتفع لوجود **الضرورة الطبية المجتمعية** .

ثالثًا: أدلة القول الثاني (المنع)

الدليل الأول – النهي عن قتل النفس: قال تعالى: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا» . وجه الدلالة: نهى الله صراحةً عن قتل النفس، وجاء النهي عامًا من غير تحديد لوسيلة القتل، وإخضاع الشخص نفسه للتجارب يعتبر من وسائل قتل النفس، فكان محرمًا.

الدليل الثاني – آية التكريم: قال تعالى: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا» . وجه الدلالة: من مقتضيات التكريم **صيانة جسمه عن العبث**، والتجارب تؤدي لا محالة إلى العبث بجسمه، فتنافي الكرامة.

الدليل الثالث – حديث الوعيد لمن قتل نفسه: ما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا» . وجه الدلالة: بَيَّنَ النبي ﷺ عِظَمَ عقوبة من قتل نفسه، والتجارب منها ما هو خطير مميت، فالإقدام عليها غير جائز لدخوله في تعمد قتل النفس.

الدليل الرابع – من المعقول: عدم ملكية الجسد: إن الإنسان لا يملك الحق في التصرف في جسده؛ لأن جسده **أمانة يسأله الله عنها**. قال النبي ﷺ: «لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، وَعَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ» ، وفي رواية: «وعن جسده فيما أبلاه» .

الدليل الخامس – انعدام الضرورة: عدم وجود الضرورة في إخضاع إنسان سليم أو مريض لتجربة علمية **لا تعود عليه بالفائدة**؛ لأن مشروعية التجارب مرتبطة بالفائدة التي تعود على الخاضع لها، ولا تكون إلا إذا تعلقت بالبحث عن دواء لمرض أَخْفَقَتِ الوسائل الموجودة في علاجه.

القول الراجح: يترجح – والله أعلم – قول من قال بـ**جواز إجراء التجارب الطبية على الأحياء وفق ضوابط محددة**، وذلك لما يلي:

١: التجارب تؤدي إلى تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة وهو **حفظ النفس**، وحفظ النفس لا يتم إلا بالتداوي عن طريق العلاجات النافعة، وهو ما لا يتم إلا بإجراء التجارب.

٢: إذا تمت وفق الضوابط فليس فيها أدنى اعتداء على حرمة الجسم البشري، لما تؤدي إليه من التأمين الكامل وإزالة العوائق.

يقول **الغزالي**: «مقصود الشرع من الخلق خمس، وهو أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، وكل ما يفوت هذه الأصول فهذه مفسدة، وكل ما يحقق هذه الأصول فهذه مصلحة.».

خامسًا: الموقف القانوني

يتفق الفقه والقضاء على **مشروعية التجارب العلاجية** على الإنسان، ويبررون ذلك بـ:

١ إن الغرض الرئيس من الأعمال الطبية هو **تحقيق الشفاء**، فما دامت التجارب تؤدي إليه كانت مشروعة.

٢ إن التجارب باتت **ضرورةً لا مناص منها** بسبب محدودية التجارب على الحيوان والاختلافات الفيزيولوجية بينه وبين الإنسان.

٣ عدم تعارضها مع القواعد القانونية العامة المنظمة للأعمال الطبية، حيث يتفق الغرض.

تأسيس المشروعية: وتعتبر فكرة **العدالة** من الأفكار المؤسسة للمشروعية، إلا أن التسليم بها لم يكن محل اتفاق، واعتمد الاتجاه المؤيد على فكرة **المصلحة**: تحقيق مصلحة عامة بإيجاد وسائل علاج جديدة، ويرتبط هذا بفكرة الحق في سلامة الجسم: فمبدأ معصومية الجسد يرد عليه حقان: حق خاص للفرد، وحق عام للمجتمع. وذهب البعض إلى تأسيس المشروعية على فكرة **السبب**: فما دام السبب مشروعًا كان الفعل مباحًا، ويرى بعض الفقه الفرنسي حظر التجارب على المحكوم عليهم بالإعدام دون غيرهم.

يقول **المادة ٤٣ من الدستور المصري**: «لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على إنسان بغير رضائه الحر.».

٢ المطلب الثاني: حكم إجراء التجارب الطبية على الأموات

تبرز الفلسفة الإسلامية في التعامل مع الإنسان حيًا وميتًا، وقد كان اهتمام الإسلام بالميت ذا طبيعة خاصة؛ حيث إن الميت منعدم الإرادة، ولا قوة له، ومن الأحكام:

أمر الإسلام بتكريم الميت: قال النبي ﷺ: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يُبْعَث يوم القيامة ملبيا» .

نهى عن إيذاء الميت: قال النبي ﷺ: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» .

الحماية القانونية الدولية للميت: أولت المواثيق الدولية الميت حماية كاملة (**الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ١٩٤٨م، اتفاقية منع إبادة الجنس البشري ١٩٤٨م، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ١٩٦٦م، الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان**).

أولًا: تاريخ التجارب على الأموات

التحنيط: حفظ جثث الموتى من التلف (**المصريون القدماء**).

التشريح: قام أطباء قديمًا – مسلمين وغير مسلمين – بتشريح جثث الموتى، واشتهر **جالينوس** حيث ألف سبع عشرة مقالة في تشريح الموتى، والادعاء بأن المسلمين لم يعرفوا التشريح مخالف للحقيقة؛ فالأطباء المسلمون عرفوه ومارسوه، ومقولة ابن رشد: «*من اشتغل بالتشريح ازداد إيمانًا بالله*»، وكانت مدرسة الإسكندرية أول مدارس العالم في تدريس التشريح.

ثانيًا: تحرير محل النزاع

١ لا خلاف في جواز الأعمال الطبية على أجساد الموتى إذا كانت تهدف إلى **إثبات حق أو نفي تهمة** (التشريح الجنائي).

٢ لا خلاف في جواز التصرفات التي يُقْصَدُ منها **دفع وباء عن المجتمع**.

موضع الخلاف: والخلاف وقع في التجارب بقصد **التعليم أو تحقيق اكتشافات طبية** .

القول الأول (المنع): ذهب إليه **الحنابلة** تخريجًا على قولهم في حكم شق بطن المرأة لإخراج جنينها الحي. قال ابن قدامة: «*والمرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك، فلا يشق بطنها ويسطو عليه القوابل*». ومن المعاصرين: الشيخ محمد بخيت المطيعي والشيخ محمد برهان الدين السنبهلي.

القول الثاني (الجواز): يمكن نسبته إلى **الحنفية والشافعية والظاهرية**، وهو قول عامة المعاصرين (الشيخ حسنين مخلوف، الشيخ إبراهيم اليعقوبي، الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي)، ومن الهيئات: هيئة كبار العلماء بالسعودية، دار الإفتاء المصرية، المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، لجنة الفتوى بالأردن.

سبب الخلاف

التعارض بين **حق الميت في التكريم**، و**حق المجتمع في الحصول على المنفعة المتحصلة من التجربة**.

أدلة القول الأول (المنع)

الدليل الأول – آية التكريم: قال تعالى: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا» . وجه الدلالة: التكريم يقتضي تحريم إهانته، وفي التجارب على الموتى إهانة.

الدليل الثاني – حديث النهي عن المثلة: ما روي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ: قال النبي ﷺ «اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تَمْثُلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا» . وجه الدلالة: نهى عن المثلة (تشويه خلقة القتيل)، والتجارب يتم فيها ذلك، والنهي عن التمثيل بجثث الأعداء غير المسلمين، فبالأولى المسلم، والنهي في الحرب، ففي السلم أولى.

الدليل الثالث – حديث كسر عظم الميت: قال النبي ﷺ: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» . وجه الدلالة: أثبت حرمة جسد الميت كحرمة الحي، والتجارب تشتمل على كسر وتقطيع.

الدليل الرابع – النهي عن الإيذاء المعنوي: قال النبي ﷺ: «لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا» ، وقال ﷺ: «اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ» . فإذا نهى عن الإيذاء المعنوي، فالنهي عن التجارب التي تطول جسده أولى.

الدليل الخامس – القواعد الفقهية: قاعدة «الضرر لا يُزَال بالضرر». وقاعدة «لا ضرر ولا ضرار».

أدلة القول الثاني (الجواز)

الدليل الأول – آية إحياء النفس: قال تعالى: «وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا» . وجه الدلالة: عَظَّمَ الله ثواب إحياء النفس ولم يحدد الطريقة. وقال الحسن: «*من إحيائها أن يُنَجِّيها من القود، فيعفو عنها، أو يفاديها من العدوان، وينجيها من الغرق، ومن الحرق، ومن السبع، وأفضل إحيائها أن ينجيها من كفرها وضلالها*». وقال ابن الجوزي: أورد في معنى الإحياء خمسة أقوال أحدها: استنقذها من هلكة.

الدليل الثاني – رعاية المصالح: للتجارب فوائد عظيمة على المستويين الفردي والجماعي، ومن المسلم به شرعًا وعقلًا أن الشريعة راعت مصالح العباد، ويُرتكب الضرر الأخف لإزالة الضرر الأشد.

الدليل الثالث – القياس على استخدام أعضاء الميت: أفتت دار الإفتاء المصرية بجواز سلخ جلد الميت لعلاج حروق الأحياء، وأجازت هيئة كبار العلماء نقل قرنية عين من إنسان بعد موته وزرعها في عين مسلم مضطر، غلب على الظن نجاحها ما لم يمنع أولياؤه ذلك. فإذا جاز استخدام بعض أعضاء الميت لإحياء شخص، فمن باب أولى يجوز إجراء التجارب عليه لإحياء أمة.

الدليل الرابع – القياس على أكل المضطر من الميت: إن الفقهاء أجازوا الأكل من الميت في حالة الضرورة استبقاءً للحياة، وفي التجارب استبقاء لأحياء بإتلاف أجزاء من الميت.

الدليل الخامس – ترجيح المصلحة العامة: إن التجارب تشتمل على مفاسد، إلا أن المصالح تترجح عليها؛ لأنها مصالح عامة تؤدي إلى حفظ النفوس، ومصلحة الميت خاصة ومصلحة المرضى عامة، وعند التعارض تقدم العامة.

MNARA 01105405478

الدليل السادس – القاعدة الفقهية: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب». قال النبي ﷺ:

«تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً، إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً، إِلَّا الْمَوْتَ، وَالْهَرَمَ»

. وإذا كان التداوي واجبًا ولا يتم إلا بإيجاد الأدوية، والتجارب أحد العوامل الرئيسة، فتكون جائزة.

الدليل السابع – القياس على شق بطن الحامل: القياس على شق بطن المرأة الحامل إذا ماتت وجنينها حي، حيث ذهب الجمهور إلى جوازه، فإذا أُبيح لإحياء نفس واحدة، فمن باب أولى لإحياء أمة.

الدليل الثامن – حكم الوسائل: حكم الوسائل متعلق بحكم المقاصد، والهدف تحقيق النفع للبشرية، فيكون الحكم الجواز.

يقول **الغزالي**: «وَمَقْصُودُ الشَّرْعِ مِنْ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ: وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ، فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ.».

القول الراجح: يترجح – والله أعلم – قول من قال بـ**جواز إجراء التجارب على الموتى**، وذلك

١: قوة أدلة هذا الرأي وسلامتها من المناقشة.

٢: الموازنة بين المصالح والمفاسد توجب ترجيح الجواز؛ حيث إن مصلحة الحي بإنقاذ حياته أعظم من مصلحة الحفاظ على حرمة جسد الميت لاسيما وأنه صار جسدًا بلا روح.

توضيح للترجيح : هذا الترجيح لا يعني إهدار حرمة الميت، بل يعني أن الحرمة تُصان في الحدود التي لا تتعارض مع حفظ أرواح الأحياء، فالإسلام يقدم حفظ الحياة على حفظ الجسد، لأن الحياة مقصد أصلي والجسد وسيلة.

٣ المطلب الثالث: حكم إجراء التجارب العلاجية على البويضات الملقحة

بعد أن ناقشنا التجارب على الأحياء والأموات، ننتقل لمنطقة فقهية أكثر تعقيدًا: البويضات الملقحة الفائضة من عمليات الإنجاب الصناعي، هل هي جنين له حرمة؟ أم مجرد خلايا لا حكم لها؟ الإجابة تتوقف على مسألة دقيقة: **متى تُنفخ الروح؟**

في الإنجاب الصناعي يعمد الأطباء إلى تنشيط المبيض لإفراز عدد من البويضات، ثم تلقيحها وحفظها، بحيث إذا فشلت المحاولة يمكن إعادة الزرع، فإذا نجحت العملية تبقى بويضات

ملقحة فائضة قابلة للزرع. وهذه البويضات تمر بمراحل:

- **مرحلة ما قبل الجنين**: الأسبوع الأول (٨ أو ١٦ خلية).
- **مرحلة الجنين**: بعد وصول الخلايا إلى ٣٢ خلية فأكثر.

أولًا: مدى اعتبار البويضة الملقحة جنينًا

الجنين في اللغة: مأخوذ من الجن وهو الستر، سُمِّيَ لاستتاره في بطن أمه.

المذهب / العالم	التعريف الاصطلاحي
الحنفية	ما استبان من خَلْقِهِ شيء، فإن لم يَسْتَبِنْ شيء فليس بجنين.
المالكية	كُلّ ما حملته المرأة مما يُعْرَفُ أنه ولد.
الشافعية (الغزالي)	النطفة إذا وقعت في رحم المرأة واختلطت بمائها، وزاد: المُعَوَّل عليه أن يستبين شيء من خلقه، وإلا فلا بد من شهادة أربع نسوة من القوابل الثقات، أو عالمين في الطب الشرعي أو علم الأجنة أن المضغة فيها تخطيط لآدمي.
الحنابلة	ما كان فيه صورة آدمي، وقبل ذلك لا يُعْلَمُ يقينًا أنه جنين.
ابن رجب وابن حزم	بَدء اعتبار ما في الرحم جنينًا هو كونه علقة.

في الطب: يُطلق لفظ الجنين على الولد عندما يظهر **الطابع الإنساني** (بين الشهر الثالث والولادة)، ويُقصره بعضهم على ما بين بداية الشهر السابع والولادة، ومن علماء الأجنة من يطلقه على الفترة بين انغراس البويضة ونهاية الأسبوع الثامن، ثم «حميل» إلى الولادة.

موقف الفقهاء من البويضة المخصبة

- **الحنفية:** البويضة المخصبة قبل نفخ الروح لا حياة لها ولا تعتبر جنينًا. وقال ابن عابدين: «*إنما يباح للمرأة استنزال الجنين قبل نفخ الروح؛ لأنه ليس بآدمي*».
- **الشافعية:** لا يعتبر جنينًا قبل أربعة أشهر، فلا يغسل ولا يصلى عليه.
- **ابن قدامة:** الجنين قبل نفخ الروح لا حياة فيه، بل هو الجماد والدم.
- **ابن حزم:** الجنين قبل نفخ الروح فيه لا شيء ولا حياة له.

أسباب عدم اعتبار البويضة الملقحة جنينًا قبل نفخ الروح

الحياة لم تدب فيه حقيقة؛ إذ الحي جسد وروح، والجنين قبل الأربعة أشهر **جسد بلا روح**.

٢ الجنين يتكون من الحيوان المنوي والبويضة، ومعنى «جنين» الاستتار في بطن الأم، وحرمة البويضة الملقحة يرتبط بمكان وجودها؛ فقيمتها إذا كانت في الرحم، أما **خارج الرحم فلا تعتبر جنينًا** .

٣ هذا القول **مُؤَيَّد بالعلم الحديث**: البويضة لا تعتبر حملًا إلا إذا اندمجت في أنسجة الرحم.

٤ خروج الروح سبب إنهاء الحياة، فوجودها سبب وجودها، والحياة الإنسانية لا تدب إلا بعد نفخ الروح، وقبلها حياة نباتية.

٥ الحياة الإنسانية لا تبدأ إلا من وقت نفخ الروح، إذ يصبح الجنين خَلْقًا آخر فيه قوى الوعي والإدراك والتمييز.

ندوة رؤية إسلامية لبعض الممارسات الطبية: قررت أن **الوضع الأمثل** ألا يكون هناك فائض من البويضات الملقحة، وتوصي ألا يعرض العلماء للتلقيح إلا العدد الذي لا يسبب فائضًا، أما إذا حصل فائض فترى الأكثرية أن البويضات الملقحة **ليس لها حرمة شرعية** .

ثانيًا: وقت نفخ الروح في الجنين

١ **الاتجاه الأول – ١٢٠ يومًا (أربعة أشهر):** ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيُقَالُ لَهُ: اكْتُبْ عَمَلَهُ، وَرِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ» .

٢ **الاتجاه الثاني – ٤٢ ليلة:** ما رواه حذيفة بن أسيد: «إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً، بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكًا، فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ أَجَلُهُ، فَيَقُولُ رَبُّكَ مَا شَاءَ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ رِزْقُهُ، فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَخْرُجُ الْمَلَكُ بِالصَّحِيفَةِ فِي يَدِهِ، فَلَا يَزِيدُ عَلَى مَا أُمِرَ وَلَا يَنْقُصُ» .

3 **الاتجاه الثالث – ١٣٠ يومًا:** قول ابن عباس وسعيد بن المسيب. قال ابن عباس: «*إذا وقعت النطفة في الرحم مكثت أربعة أشهر وعشرًا، ثم ينفخ فيه الروح*». تقييمه: غير مقبول؛ لأنه لم يقل به أحد مع كثرة الأقوال، وقول النبي ﷺ مقدم على قول الصحابة والتابعين.

4 **الاتجاه الرابع – لحظة التلقيح (الزيجوت):** وهو ما ذهب إليه الغزالي. قال: «*أول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم، وتختلط بماء المرأة، وتستعد لقبول الحياة، وإفساد ذلك جناية، فإذا صارت مضغة وعلقة كانت الجناية أفحش، وإذا نفخ فيه الروح...*». ومفاده أن الحياة سابقة على نفخ الروح، ونفخ الروح طَوْرٌ من أطوار النمو وليس بداية له.

ثالثًا: الرأي الراجح في وقت نفخ الروح

نفخ الروح لا يكون إلا بعد **أربعة أشهر** ، لوضوح دلالة حديث ابن مسعود، والجمع بينه وبين حديث حذيفة:

١ إرسال الملك على التعدد: مرة في بداية الأربعين الثانية، وأخرى في نهاية الثالثة لنفخ الروح.

٢ كلا التقديرين حق: الأول عند انتقال النطفة لأطوار التخليق، والثاني عند كمال الخلق ونفخ الروح.

٣ الكتابة بعد الأربعين الأولى، والتصوير والنفخ بعد الثالثة.

٤ حديث ابن مسعود **مُفَسِّرٌ** للأحاديث الأخرى.

٥ معنى «جمع الخلق» فسره ابن القيم بأنه تخطيط أعضاء الجنين وتصويرها تصويرًا خفيفًا في الأربعين الأولى.

٦ العلماء المسلمون قديمًا أدركوا أن الجنين يكتمل نموه قبل الأربعة أشهر، ولا تعارض مع أن نفخ الروح بعدها.

يقول **النووي**: «... لأن نفخ الروح لا يكون إلا بعد تمام صورته.».

رابعًا: حكم إجراء التجارب على البويضات الملقحة

عند بيان الحكم يقتضي التفريق بين أمرين:

MARA 01105405478

⊘ **الأمر الأول: تلقيح بويضات لغرض إجراء التجارب عليها** **لا يجوز شرعًا** ، وذلك لأن:

- التلقيح الصناعي حَادَ عن هدفه (معالجة العقم)، وقد قَرَّرَ الفقهاء أنه يكتسب الجواز مادام يسير وفق القواعد الموضوعة.
- يتنافى مع التكريم: قال تعالى «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ» .

⊘ **الأمر الثاني: البويضات الفائضة من عمليات الزرع** لا يمكن اعتبارها أجنة مجهضة؛ لأن المجهضة ميتة غير قابلة للحياة، أما الفائضة فقابلة للحياة إذا تهيأت الظروف، والأجنة الميتة لا فائدة من إجراء التجارب عليها.

يقول **النبي** ﷺ: « «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ» ».

تصنيف اللجان للأجنة المجهضة – ثلاثة أقسام

1. **القسم الأول – غير قابلة للحياة:** ما قبل الأسبوع ٢٠: يُسمح باستخدامها بشرط **موافقة الأبوين**.
2. **القسم الثاني – قابلة للحياة:** الأسبوع ٢٤ فما بعد، وزن ٤٠٠-٥٠٠ جم: **لا يُسمح باستخدامها** إلا بعد وفاتها الطبيعية.
3. **القسم الثالث – بين ٢٠ و ٢٤ أسبوعًا:** يُسمح باستخدام ما يزن ٣٠٠ جم فما دونها.

الضوابط القانونية: صدر **قانون الإخصاب وعلم الأجنة البشرية البريطاني (١٩٩٠م)**، و**قانون أخلاقيات العلوم الإحيائية الفرنسي (١٩٩٤م)**، وضعا ضوابط منها: ضرورة الحصول على رخصة مزاولة، احترام ضمانات الحفظ والاستخدام، **يمنع منعًا باتًا البيع والشراء والاتجار أو الاستنساخ البشري** . وفي جميع الأحوال يجب ألا تخرج البحوث عن الحدود الشرعية والأخلاقية والقانونية، فلا يكون هدفها الحصول على أعضاء للنقل، أو إشباع شهوة علمية، أو تغيير البنية

الأساسية (تغيير الجنس، التحكم في الكروموسومات، الإخصاب بين الإنسان والحيوان)، أو التلاعب بمقدرات الجنس البشري.

المبحث الثالث: القيود الواردة على إجراء التجارب الطبية على البشر

في المبحث الثاني قررنا **الجواز المشروط**، وهذا المبحث هو بيان تلك الشروط، فبدون هذه القيود يعود المنع، لأن الجواز هنا **استثناء من الأصل** ، والاستثناء لا يتوسع فيه. فالقول بالجواز على إطلاقه دون ضوابط قد يؤدي إلى التلاعب، لذا هناك قيود: منها ما يتعلق بالتجربة ذاتها، ومنها ما يتعلق بالشخص الخاضع لها، ومنها ما يتعلق بحماية المجتمع.

❶ المطلب الأول: القيود الخاصة بالتجربة

القيد الأول: أن يكون الهدف من التجربة هو العلاج

يجب أن يكون الغرض إيجاد العلاج الفعال لمرض يصيب الإنسان، سواء بتصنيع الدواء أو ابتكار وسائل جديدة أو تحسين الطرق الموجودة، وإذا حادت التجربة عن هذا الهدف (كأن تتخذ وسيلة للشهرة أو إشباع الفضول العلمي فقط) كانت غير مشروعة. ولا يكفي مجرد استهداف العلاج؛ بل ينبغي أن يكون **حقيقيًا معتمدًا على حقائق ثابتة** لا أوهام، وقد استقر الفقه والقضاء في فرنسا على تقرير مسئولية الطبيب إذا لم يكن القصد العلاج. وبمقتضى هذا القيد ينبغي **ألا يكون أمام الطبيب وسيلة أخرى للعلاج** ، وأن تكون النتائج الإيجابية المتوقعة أكثر بكثير من المخاطر.

القيد الثاني: أن تتم التجربة وفقًا للأسس العلمية المتعارف عليها

يجب أن تبتعد التجارب عن الأهواء الشخصية والخيالات العلمية، والسبب: أن محلها الإنسان، وقيامها على أسس غير صحيحة يُعَرِّضُ حياته للخطر المحقق. ويترتب على ذلك أن يكون الطبيب على قدر وافر من الكفاءة، عالِمًا بآخر ما توصل إليه العلم، وقد أشار **إعلان هلسنكي** في المبدأ الأول إلى ضرورة ذلك.

مراحل التجربة

1. **المرحلة الأولى:** إجراؤها على حيوانات تتشابه مع الإنسان بيولوجيًا.
2. **المرحلة الثانية:** تسجيل جميع الملاحظات والنتائج.

3 **المرحلة الثالثة:** إخضاع النتائج للدراسات والمناقشات.

4 **المرحلة الرابعة:** وضع تقرير مفصل قبل البدء.

5 **المرحلة الخامسة:** الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة الطبية والشرعية المختصة.

يقول **الشافعي**: «وَإِذَا أَمَرَ الرَّجُلُ أَنْ يَحْجُمَهُ أَوْ يَخْتِنَ غُلَامَهُ أَوْ يُبَيْطِرَ دَابَّتَهُ فَتَلِفُوا مِنْ فِعْلِهِ فَإِنْ كَانَ فَعَلَ مَا يُفْعَلُ مِثْلُهُ مِمَّا فِيهِ الصَّلَاحُ لِلْمَفْعُولِ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِتِلْكَ الصَّنَاعَةِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ فَعَلَ مَا لَا يُفْعَلُ مِثْلُهُ مَنْ أَرَادَ الصَّلَاحَ وَكَانَ عَالِمًا بِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ.».

القيد الثالث: انعدام الخطر في التجربة

ألا يكون فيها تعريض حياة الخاضع لها للخطر أو إصابته بضرر مستديم، والسبب: 📝 قاعدة « **لا ضرر ولا ضرار** » وهي أصل في تحريم التجارب المؤدية لأضرار، مع اغتفار الضرر اليسير غير المؤثر.

القيد الرابع: توافر الكفاءة العلمية في القائم بالتجربة

والطبيب بالمفهوم العام: العارف بتركيب البدن والأمراض والأدوية وطريق مداواتها.

يقول **أبو بكر الرازي**: «إن الطبيب يجب أن يرجع إلى الأصول الثابتة في علم الطب، وخواص الأشياء المستعملة في العلاج، ولا ينظر إلى ما يهذي به الجهال أن فلانًا قد وقعت له التجربة في غير علم يرجع إليه.».

يقول **ابن مفلح**: «وَلَا ضَمَانَ عَلَى حَجَّامٍ وَلَا خَتَّانٍ وَلَا طَبِيبٍ وَلَا بَيْطَارٍ عُرِفَ حِذْقُهُمْ وَلَمْ تَجْنِ أَيْدِيهِمْ.».

الجانب الأول: العلوم الطبية **الثابتة**.

الجانب الثاني: العلوم الطبية **المستجدة**.

وتتطلب الكفاءة أيضًا: أن يكون **مصرحًا له بمزاولة المهنة**، وأن يكون متمتعًا باللياقة والنزاهة والتسوية بين المرضى.

القيد الخامس: ازدياد احتمالات نجاح التجربة

أن تكون الأخطار **مقبولة** مقارنة بالمنفعة المتوخاة، مع تحقيق التوازن بين نتائج التجربة وعواقب المرض.

القيد السادس: إجراء التجربة على الحيوانات مسبقًا

يشترط البعض إجراءها مسبقًا على الحيوانات **القريبة من الإنسان تكوينًا**، بنتائج إيجابية تشجع على إجرائها على الإنسان، للحد من الأضرار.

٢ المطلب الثاني: القيود الخاصة بالأشخاص الخاضعين للتجارب

القيد الأول: الرضا بإجراء التجربة

اشترط القائلون بالجواز الرضا من قِبَل الخاضع للتجربة، ليتوافق مع طبيعة العلاقة بين الطبيب والمريض، وإذا كان الفقهاء اشترطوا الرضا في عقد العلاج المألوف، فمن باب أولى في التجارب غير المألوفة.

شروط الرضا

١ **التكليف** لا يصح الرضا إلا من البالغ العاقل. قال النبي ﷺ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ، عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ». وقال الآمدي: «*المجنون والصبي الذي لا يميز، فهو بالنظر إلى فهم التفاصيل كالجماد والبهيمة بالنظر إلى فهم أصل الخطاب... وأما الصبي المميز وإن كان يفهم ما لا يفهمه غير المميز، غير أنه أيضًا غير فاهم على الكمال ما يعرفه كامل العقل*».

٢ **أن يصدر عن إرادة حرة** خالية من عيوب الإرادة (إكراه، غش، تدليس).

صور الإذن

الإذن المطلق: السماح بأي عمل طبي يراه الطبيب مفيدًا.

الإذن المقيد: تقييد الطبيب بالتجربة فقط، وشروطه:

- أن يصدر ممن يملك الحق مع توافر الأهلية.
- أن تكون الصيغة **صريحة** (والإذن الضمني لا يعتد به لخطورة المسألة).
- أن تكون التجربة مشروعة.
- أن يتم الحصول على الإذن **قبل المباشرة**.

يقول **ابن القيم**: «لا يجوز الإقدام على قطع عضو لم يأمر الله ورسوله بقطعه ولا أوجب قطعه، كما لو أذن له في قطع أذنه أو أصبعه، فإنه لا يجوز له ذلك، ولا يسقط الإثم عنه بالإذن.».

التبصير والكذب في التجارب: ويوجب اشتراط الرضا التزامًا بـ**تبصير المريض** بطبيعة التجربة والمخاطر، وأي كذب أو إخفاء معلومات يستوجب المسؤولية. ووجد اتجاه يرى جواز الكذب في حدود: **الكذب المتشائم** (الممنوع): إخفاء النتائج الحسنة. **الكذب المتفائل** (المسموح): إخفاء حقيقة المرض وعواقبه. إلا أن الكذب بكل أنواعه **ممنوع في نطاق التجارب الطبية** ، ويجب التبصير بصدق وشفافية. ولماذا مُنع الكذب في التجارب بينما قد يُسمح به في العلاج العام؟ لأن المريض في العلاج العام يخضع لعلاج معتمد ومعروف المخاطر، أما في التجربة فهو يواجه مجهولًا، فأي إخفاء للمعلومات يحرمه من حق اتخاذ قرار مستنير بشأن جسده.

الرضا من القاصر

اتفق الفقهاء على أن إذن القاصر **كعدمه**.

يقول **المغني**: «وَإِنْ خَتَنَ صَبِيًّا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ، أَوْ قَطَعَ سِلْعَةً مِنْ إنْسَانٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَوْ مِنْ صَبِيٍّ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ، فَسَرَتْ جِنَايَتُهُ، ضَمِنَ؛ لِأَنَّهُ قَطْعٌ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ، وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ الْحَاكِمُ، أَوْ مَنْ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَيْهِ، أَوْ فَعَلَهُ مَنْ أَذِنَا لَهُ، لَمْ يَضْمَنْ؛ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ شَرْعًا.».

يقول **الشافعي**: «وَلَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِصَبِيٍّ لَيْسَ بِابْنِهِ وَلَا مَمْلُوكِهِ وَلَيْسَ لَهُ بِوَلِيٍّ إِلَى خَتَّانٍ أَوْ طَبِيبٍ فَقَالَ: اخْتِنْ هَذَا أَوْ بُطَّ هَذَا الْجُرْحَ لَهُ أَوْ اقْطَعْ هَذَا الطَّرَفَ لَهُ مِنْ قُرْحَةٍ بِهِ فَتَلِفَ كَانَ عَلَى عَاقِلَةِ الطَّبِيبِ وَالْخَتَّانِ دِيَتُهُ وَعَلَيْهِ رَقَبَةٌ وَلَا يَرْجِعُ عَاقِلَتُهُ عَلَى الْآمِرِ بِشَيْءٍ وَهُوَ كَمَنْ أَمَرَ رَجُلًا بِقَتْلِ.».

ومضمون ما سبق أن الأعمال الطبية التي تجري على جسد القاصر يلزم فيها إذن الولي، إلا أن الولي **مقيد بما فيه مصلحة القاصر**.

MARA 01105405478

إشكال وحل: قد يتبادر إلى ذهنك أن اشتراط إذن الولي يعني توقف الأطباء عن إنقاذ الأطفال في الحوادث، لحل هذا الإشكال، قسّم الفقهاء والأطباء الأعمال الطبية على جسد القاصر إلى **ثلاثة أقسام عملية**:

1. **القسم الأول – الأعمال الطبية العاجلة:** وهي التي تتطلب تدخلًا سريعًا حفاظًا على حياة القاصر (كحوادث السير والنزيف الحاد)، ففي هذه الحالات **لا يتوجب انتظار إذن الولي** ، وعلى الطبيب التدخل السريع وفق الأصول الطبية.
2. **القسم الثاني – الأعمال الطبية غير العاجلة:** وهي التي لا تتطلب سرعةً ويمكن تأخيرها (كاستئصال اللوزتين أو تقويم الأسنان)، فلا يجوز الإقدام عليها إلا **بإذن الولي**، وإن قام بها الطبيب دون إذنه وتلف منه شيء كان ضامنًا.
3. **القسم الثالث – الأعمال الطبية الخطيرة/التجارب:** ويمثل لها بالتجارب الطبية، ويُفرق فيها بين نوعين:

- **التجارب الخطيرة**: التي يحتمل فيها هلاكه أو إصابته بعاهات وتشوهات، وهذا النوع **يحرم الإقدام عليه شرعًا** ، ولا عبرة بموافقة الولي؛ لأن الإذن خارج عن حدود الولاية، وإن أذن الولي صار ضامنًا.
- **التجارب العادية**: التي لا تحمل خطرًا، فإن كان فيها مصلحة للقاصر (كعلاجه) فلا حاجة لإذن الولي، أما إن كانت لغرض التقدم الطبي دون مصلحة مباشرة للقاصر، فلا يجوز إجراؤها ولو أذن الولي؛ لما تنطوي عليه من آثار نفسية سيئة.

يقول **مجمع الفقه الإسلامي (قرار رقم ٦٧/٥/٧)**: «لا بد في إجراء الأبحاث الطبية من موافقة الشخص التام الأهلية، بصورة خالية من الإكراه... ويجب ألا يترتب على إجراء تلك الأبحاث ضرر ولا يجوز إجراء الأبحاث الطبية على عديمي الأهلية أو ناقصيها ولو بموافقة الأولياء.».

يقول **ابن القيم**: «طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها، فقطع صبي من رجل أو مجنون بغير إذنه أو إذن وليه أو ختن صبيًا بغير إذن وليه فتلف، فقال أصحابنا يضمن لأنه تولد من فعل غير مأذون فيه... ويحتمل أن لا يضمن مطلقًا؛ لأنه محسن، وما على المحسنين من سبيل.».

القيد الثاني: الرضا من الأسرى والمسجونين والمحكوم عليهم بالإعدام

تُعد مشكلة الرضا من هذه الفئة بالغة الأهمية؛ لأنهم يفقدون جزءًا من إرادتهم، وقد يُنتزع الرضا تحت الضغط أو الإكراه، أو مقابل تخفيف العقوبة.

المساجين والمحكوم عليهم: ذهب البعض إلى وجوب حظر التجارب عليهم، إلا أن هذا الحظر الشامل يُعد تفرقة لا مبرر لها، والصواب اتخاذ تدابير خاصة لحمايتهم.

أسرى الحرب: الأسير لا يمكن الحكم عليه بذي إرادة حرة تمامًا، وتصرف الإمام في الأسرى منوط بمصلحة الجماعة (القتل، المن، الفداء، الاسترقاق، عقد الذمة)، فيجوز إجراء التجارب عليهم بشروط: ألا تكون مضرة، وألا تؤثر على أجسادهم، مع توافر **الرضا التام المستنير**، فإن رفض الأسير فلا يجوز إجباره.

يقول **مجمع الفقه الإسلامي (قرار رقم ٦٧/٥/٧)**: «لا بد في إجراء الأبحاث الطبية من موافقة الشخص التام الأهلية بصورة خالية من شائبة الإكراه – كالمساجين – أو لأغراض مادية – كالمساكين – ويجب ألا يترتب على إجراء تلك الأبحاث ضرر.».

ربط تفسيري: لاحظ أن الفقه الإسلامي هنا **أكثر تقدمًا وإنسانية** من بعض التطبيقات الغربية التاريخية التي كانت تستخدم السجناء كـ«فئران تجارب» قسرًا، الإسلام اشترط « **الرضا الخالي من شائبة الإكراه** »، وهو ما يصعب تحققه في بيئة السجن، مما يجعل القاضي الشرعي في غاية التدقيق عند الموافقة على مثل هذه التجارب.

القيد الثالث: الرضا في التجارب على الموتى

مبدأ الرضا يسري على الأموات؛ فينبغي أن يكون **صريحًا**، ويصدر من الميت قبل وفاته (بشروطه)، فإن لم يصدر منه، جاز لذوي الشأن (الأقارب) الموافقة عند **الحاجة الماسة** ، أما إذا وُجدت طرق بديلة فلا يجوز.

يقول **القانون المصري (رقم ١٣٠ لسنة ١٩٤١م - المادة ٢٦)**: «يجوز لمفتش الصحة أن يأذن بعدم دفن الجثة بناءً على طلب إحدى الجهات الصحية أو الجامعية للاحتفاظ بها لأغراض علمية، وذلك بعد موافقة ذوي الشأن من أقارب المتوفى.».

القيد الرابع: التبصير بطبيعة التجربة ومدى خطورتها

لم يكتفِ الفقهاء والقانونيون بمجرد الرضا، بل أوجبوا أن يكون صادرًا عن **إرادة مستنيرة**؛ لأن الطبيب يحوز كمًّا هائلًا من المعلومات يجعل المريض في مركز غير متعادل (عالم يواجه جاهلًا)، ويجب أن تُقسم المخاطر إلى: **مقبولة** (يمكن إجراء التجربة معها)، و**غير مقبولة**.

مبادئ القانون الطبي الأمريكي: تشترط الموافقة الحرة والمستنيرة، حماية الحياة الخاصة، الحرص على الحياة والصحة، وتقليل الأخطار.

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (١٩٩٧م): اشترطت سبعة شروط، منها: الرضا المستنير، انعدام الخطر على الحياة، عدم إخضاع الشخص لتجارب متعددة معًا، الإشراف الطبي عالي الكفاءة، انعدام البدائل، الموافقة الإدارية، والتأمين من المسؤولية.

٣ المطلب الثالث: القيود الخاصة بحماية المجتمع

القيد الأول: اتفاق التجارب الطبية مع قواعد النظام العام

ينبغي ألا تؤدي التجارب إلى الإضرار بالمجتمع أو مخالفة ثوابت الشريعة، ومن ذلك تحريم التجارب التي تتم بغرض **تغيير الجنس** لمخالفتها لأمر الله.

قال تعالى: «وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ» .

فالتجارب المحرمة لا أثر لها، ولا يعتد بالموافقة الصادرة بموجبها.

يقول **ابن القيم**: «... كما لو أذن له في قطع أذنه أو إصبعه، فإنه لا يجوز له ذلك، ولا يسقط الإثم عنه بالإذن.».

القيد الثاني: الالتزام بالأحكام الشرعية

أ تجنب النظر للعورات والاطلاع عليها

النظر إلى العورات ممنوع أصلًا، إلا **للضرورة** (المداواة)، وتقدر بقدرها.

يقول **الكاساني**: «الْقَابِلَةَ، وَالطَّبِيبَ يَنْظُرَانِ إلَى الْفَرْجِ، وَيَمَسُّ الطَّبِيبُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ.».

يقول **الشربيني**: «الضرب الخامس: النظر للمداواة، كفصد، وحجامة، وعلاج ولو في فرج فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها فقط.».

يقول **ابن مفلح**: «وَلِلطَّبِيبِ النَّظَرُ إلَى مَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَى نَظَرِهِ، وَلَمْسِهِ حَتَّى دَاخِلِ الْفَرْجِ.».

📖 **سنة النبي ﷺ مع بني قريظة – دليل عملي على ذلك:** قال عطية القرظي: «*كُنْتُ مِنْ سَبْيِ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَكَانُوا يَنْظُرُونَ فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَلْ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ*».
وقال ابن القيم: «*وَقَدْ كَانَ الْأَسْرَى مِنْ قُرَيْظَةَ يَدَّعُونَ عَدَمَ الْبُلُوغِ، فَكَانَ الصَّحَابَةُ يَكْشِفُونَ عَنْ مَآزِرِهِمْ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَعْلَمُونَ بِذَلِكَ الْبَالِغَ مِنْ غَيْرِهِ*».

ب عدم إفشاء الأسرار الخاصة بالخاضع للتجربة

أقر الإسلام المحافظة على الأسرار، وهو التزام أخلاقي ومهني عرف منذ العصور الفرعونية والإغريقية.

يقول **النبي** ﷺ: « «إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا» ».

يقول **النووي**: «وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجرى بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك.».

يقول **ابن الحاج**: «ينبغي أن يكون – يعني الطبيب – أمينًا على أسرار المريض، فلا يُطْلِعُ أحدًا على ما ذكره المريض، إذ إنه لم يأذن له في إطلاع غيره على ذلك.».

ويجوز الاستثناء من هذا الالتزام إذا كان إفشاء السر يدفع ضررًا عامًا عن المجتمع، تطبيقًا لقاعدة: « **يُتَحَمَّلُ الضرر الخاص لدفع الضرر العام** ».

المبحث الرابع: المسؤولية عن إجراء التجارب الطبية

تنقسم المسؤولية المدنية إلى **عقدية** و**تقصيرية**، ولا يجوز الجمع بينهما في التعويض عن ضرر واحد.

المطلب الأول: المسؤولية المدنية عن التجارب الطبية

أولًا: المسؤولية العقدية

قوامها العقد، ويشترط في عقود التجارب الطبية أن تكون **مكتوبة** حمايةً للحقوق.

يقول **إعلان هلسنكي (المادة ٣) وقانون الصحة العامة الفرنسي (المادة ٢٠٩ L)**: «يصدر رضاء الشخص الخاضع للتجربة في الشكل المكتوب.».

شروط تحققها

١ وجود عقد بين الطبيب والمريض (وهو عقد رضائي في الأصل، ولكن تشترط الكتابة للإثبات).

٢ استيفاء العقد للأركان والشروط، فكل عمل يخرج عن إطار الاتفاق (كاستعمال النطف الفائضة في الاستنساخ دون علم صاحبها) تُسأل عنه المجرب مسؤوليةً **تقصيرية**.

ثانيًا: المسؤولية التقصيرية

هي الجزاء المترتب على إخلال الطبيب بالتزام قانوني بعدم الإضرار بالآخرين، والأطباء في تحملهم الضمان **خمسة أقسام**:

1. **طبيب حاذق لم تجنِ يده:** تلف العضو أو النفس من فعله المأذون فيه ← **لا ضمان عليه** اتفاقًا.
2. **طبيب جاهل:** باشر من يَطِبُّه فتلف به، والمجنى عليه عالم بجهله وأذن له ← **لا يضمن** .
3. **طبيب حاذق أخطأت يده:** كسبقت يد الخاتن إلى عضو صحيح ← **يضمن** .
4. **طبيب حاذق أخطأ في اجتهاده:** وصف دواءً فقتله ← يُخرَّج على **روايتين**.
5. **طبيب حاذق قطع بغير إذن:** قطع سلعة أو ختن صبيًا بغير إذن وليه فتلف ← **يضمن** لتولده من فعل غير مأذون فيه.

أركان المسؤولية التقصيرية – ثلاثة

١ **الركن الأول: الخطأ الطبي** وهو تقصير في مسلك الطبيب لا يقع من طبيب يقظ في نفس الظروف، ويتضمن عنصري **التعدي** والعنصر **المعنوي** (الإدراك). من صور الخطأ في التجارب: الخطأ في فحوصات ما قبل التجربة، عدم مسايرة التطورات العلمية واستخدام قواعد قديمة، عدم

كفاءة الطبيب (فالممارس العام لا يجوز له إجراء تجربة طبية)، التقصير في بذل العناية المطلوبة وفحص المريض بدقة.

المذهب	معيار الخطأ
الحنفية	لا يضمن إلا إذا كان غير حاذق (غير متخصص)، أو إذا كان الفعل غير معتاد.
المالكية	فرقوا بين عدم المعرفة والخطأ؛ فإن أخطأ الحاذق غير المتعمد فالضمان على العاقلة، وإن كان غير حاذق فعليه العقوبة.
الشافعية والحنابلة	المعيار هو أداء العمل بدقة وموافقة أهل العلم بالصنعة.

يقول **الشافعي**: «وَإِذَا أَمَرَ الرَّجُلُ أَنْ يَحْجُمَهُ... فَإِنْ كَانَ فَعَلَ مَا يُفْعَلُ مِثْلُهُ... فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ فَعَلَ مَا لَا يُفْعَلُ مِثْلُهُ مَنْ أَرَادَ الصَّلَاحَ وَكَانَ عَالِمًا بِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ.».

إثبات الخطأ: القاعدة العامة أن **عبء الإثبات يقع على المدعي**. قال النبي ﷺ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ رِجَالٍ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» . ويواجه المريض صعوبة في إثبات الوقائع السلبية (كعدم بذل العناية)، فيلجأ القاضي إلى **الخبرة**، أو يثبت المريض واقعة إيجابية عكسية.

2 الركن الثاني: الضرر وهو الأذى الذي يصيب الإنسان في جسمه أو ماله أو شرفه أو عواطفه، وينقسم إلى:

- **الضرر المادي**: الإخلال بمصلحة ذات قيمة مالية (مصاريف العلاج، فقدان الكسب، الأضرار الجسدية).
- **الضرر المعنوي**: ما يصيب الشخص في كرامته أو شعوره (كالعجز الدائم أو التشوهات التي تسبب الأسى والحزن).

المطالبة بالتعويض :

- عند موت الخاضع للتجربة: يجوز للورثة المطالبة بناءً على قواعد المسؤولية العقدية (لأن الخطأ ينشأ من تقصير الطبيب في التزامه العقدي مع مورثهم).
- مطالبة غير الورثة: يجوز لمن كان يعولهم الميت المطالبة شخصيًا على الطبيب وفقًا لأحكام المسؤولية التقصيرية (لأنهم من الغير بالنسبة للعقد).

3 **الركن الثالث: علاقة السببية** ضرورة أن يكون **الخطأ هو السبب المباشر** في حدوث الضرر، وتحديد السببية في المجال الطبي عسير بسبب تعقد الجسم الإنساني.

- يقع على الطبيب التزام بالتأكد من حالة المريض وحساسيته قبل التدخل.
- لا يعفى الطبيب من المسؤولية إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن **سبب أجنبي** (قوة قاهرة، حادث مفاجئ، خطأ المضرور، أو خطأ الغير).
- تنتفي مسؤولية الطبيب إذا صدر خطأ من المريض (كانتحار، أو تناول أدوية أخفاها عنه، أو كذبه في معلوماته).

تدريبات: على الوحدة الأولى

١ تناول تعريف التجارب الطبية موضحًا أهميتها.

٢ قسم العلماء التجارب الطبية إلى نوعين اذكرهما، مبينًا خصائص كل منها.

٣ من الضوابط التي وضعها المجيزون لإجراء التجارب الطبية ألا يكون فيها خطر، اشرح ذلك.

٤ بين حكم إجراء التجارب الطبية على الأجنة.

٥ صارت التجارب الطبية في الواقع المعاصر ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، اشرح ذلك.

٦ بين صور الضرر في مجال التجارب الطبية.

MNAR 01105405478

القضية الثانية: حكم تأجير الأرحام

١ التعريف بتأجير الأرحام
٢ الحكم الشرعي في تأجير الأرحام
٣ نسب طفل تأجير الأرحام

تمهيد: نشأة القضية وموقعها من النوازل الطبية

إن تأجير الأرحام غربية الأصل، وفدت إلى بلاد المسلمين فوجدت معارضة شديدة، وتجاذبها العلماء بين مجيز ومانع. وقد نظمت الحديث في تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة.

وبظهور أول مولود بطريقة **طفل الأنبوب** في ١٠ نوفمبر ١٩٧٧م في بريطانيا، تولدت قضايا جديدة، منها: **بنوك المني**، و**تجميد الأجنحة**، و**زرع الخصية**، و**زرع الرحم**، و**زرع المبيض**، و**مواليد الكتالوج**، و**الحمل بعد الوفاة للزوج**.

⚠ **ملاحظة جوهرية:** ورغم أن هذا الاستئجار مباح في الغرب فإن مشاكله لا حدود لها، ووصلت إلى المحاكم؛ لأنه **يتنافى مع الفطرة السوية**، وفيه اعتراض على مشيئة الله باللجوء إلى الوسائل المحرمة، وفق قرارات المجامع الفقهية.

المبحث الأول: التعريف بتأجير الأرحام

١ تعريف الإجارة

الإجارة في اللغة

الإجارة اسم للأجرة، وهي كراء الأجير. وتستعمل في اللغة ويراد بها **الأجرة على العمل**، كما تستعمل في العقد الذي يَرِدُ على المنافع بعوض. وتطلق ويراد بها العوض، ومنه قوله تعالى: «لَوْ شِئْتَ لَتَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا» .

الإجارة في الاصطلاح – المذاهب الأربعة

المذهب	التعريف الاصطلاحي

الحنفية	عقد على المنافع بعوض هو مال، وقيل: بيع منفعة معلومة بأجر معلوم.
المالكية	تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض.
الشافعية	عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. وقيل: تمليك منفعة بعوض بشروط.
الحنابلة	عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئًا فشيئًا.

٢ تعريف الرحم في الإسلام

اهتم الإسلام برحم المرأة اهتمامًا بالغًا، فوضع له من الأحكام ما يؤدي إلى **تقديسه وعدم امتهانه**، بعد أن كان الرحم ممتهنًا في الجاهلية لا قيمة له ولا حرمة، حيث كانت الأنكحة متعددة (*نكاح الرهط، نكاح الاستبضاع*) تجعل رحم المرأة سلعة مباحة.

الرحم لغةً واصطلاحًا: لغةً: موضع تكوين الجنين ووعاؤه في البطن. **واصطلاحًا**: حويصلة صغيرة الحجم في أسفل التجويف البطني للمرأة يتسع ويكبر تبعًا لنمو الجنين إلى نهاية الحمل، ثم يعود إلى حالته الأولى تدريجيًا.

معاني الرحم في القرآن الكريم – معنيان

1. **المعنى الأول – العضو التناسلي للمرأة:** وهو المهد والمحضن للنطفة الإنسانية، ومن آياته: «هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ» ، «اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ» ، «وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ» .

2. **المعنى الثاني – صلة القرب:** وهي الصلات الناتجة عن التزاوج، ومن آياته: «وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ» ، «وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ» ، «فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ» .

الرحم في السنة النبوية

يقول **عبد الرحمن بن عوف — رضي الله عنه**: «سمعت رسول الله ﷺ يقول: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا الرَّحْمَنُ، خَلَقْتُ الرَّحِمَ، وَشَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنْ اسْمِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ» ».

يقول **أبو هريرة — رضي الله عنه**: «قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قَالَ: أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟» ».

دلالة النصوص: ومما سبق يتبين أن الله **شَرَّفَ الرحم** عن غيره من الأعضاء، لأنه منبت البذرة الإنسانية، يغذيها بدمه ويحفظها من كل سوء، حتى إذا آن موعد خروجها انقبض انقباضات متتالية حتى يخرجها سليمة.

الوصف الطبي للرحم: والرحم موضوع في وسط حوض المرأة، محميّ ومصون، وهو عضو عضلي أجوف ذو جدار ثخين، كمثري الشكل، يبلغ طوله **ثلاث بوصات** وعرضه بوصتين وسمكه بوصة في الأنثى البالغة. فإذا حملت المرأة نما الرحم حتى يملأ البطن من القص إلى العانة. وحجم تجويفه في الأنثى البالغة لا يزيد عن **ملليترين**، وفي نهاية الحمل يتسع لـ**سبعة آلاف ملليتر**، أي يتضاعف أكثر من ثلاثة آلاف مرة. ووزنه في غير الحمل لا يزيد عن خمسين جرامًا، وفي نهاية الحمل يبلغ ألف جرام أو يزيد. وهو **الجزء الوحيد في جسم المرأة** الذي له هذه القابلية للتغير السريع.

٣ تعريف إجارة الرحم

التعريف الأول وانتقاده: عرفها البعض بأنه: **موافقة امرأة على حمل بويضة ملقحة لا تنسب إليها لحساب امرأة أخرى وتسلم المولود لها بعد ولادته.**

انتقادات التعريف الأول – ثلاثة أوجه

1. **غير مانع:** غير مانع من دخول غير المعرف فيه، حيث اقتصر على موافقة امرأة على حمل بويضة ملقحة دون ذكر **العوض**، وهذا يمنع دخول الإعارة.

2. **غير جامع:** غير جامع؛ لأن المولود قد يسلم إلى امرأة أخرى غير صاحبة البويضة كما في بعض الصور.

3. **فيه تكرار:** فيه تكرار، حيث كرر لفظ المرأة، ومن شرط التعريف **الإيجاز** .

التعريف الجامع: عرفه آخرون بأنه: **عقد تتعهد بمقتضاه امرأة بشغل رحمها بحمل ناشئ عن نطفة أمشاج مخصبة صناعيًا لزوجين استحال عليهما الإنجاب لفساد رحم الزوجة.** وقيل: **عقد معاوضة على الانتفاع برحم امرأة أجنبية لغرس اللقيحة فيه على ألا ينسب المولود إليها.**

٤ دواعي اللجوء لاستئجار الأرحام

الدواعي الطبية والاجتماعية

1. **الدواعي الطبية – الصورة الأولى:** كوجود مانع طبي يمنع المرأة من استخدام رحمها، كأن تولد **بدون أعضاء تناسلية** أو بدون رحم، أو تكون مصابة بتشوهات أو مرض يجعل الحمل مستحيلًا.

2. **الدواعي الطبية – الصورة الثانية:** ألا تكون لدى المرأة القدرة على **استكمال مدة الحمل**، أو تخشى مضاعفات شديدة تهدد حياتها كتسمم الحمل.

3. **الدواعي الاجتماعية:** كأن تكون المرأة في مركز مرموق لا تستطيع مع الحمل القيام بواجباتها الوظيفية، أو تريد مولودًا بعيدًا عن **آلام الحمل والولادة** .

المبحث الثاني: الحكم الشرعي في تأجير الأرحام

بيان الحكم يقتضي بيان الصور التي يتم بها، وإعطاء الحكم في كل حالة، وذلك في **ثلاثة مطالب.**

١ المطلب الأول: صور استئجار الأرحام

الصور السبع لاستئجار الأرحام

1. **الصورة الأولى – الأجنبية:** الزرع في رحم امرأة **أجنبية** عن العلاقة الزوجية، بعد أخذ الحيوان المنوي من الزوج والبويضة من الزوجة وتلقيحهما في الخارج، ثم يعاد زرعها في رحم تلك المرأة. وهي **الأكثر شهرة** .

2 **الصورة الثانية – الزوجة الثانية (الضرة):** الزرع في رحم **الزوجة الثانية** للرجل، حيث تكون له زوجتان إحداهما سليمة المبيض معتلة الرحم، والأخرى عكسها، أو تكون الثانية سليمة من الناحيتين، فتؤخذ البويضة من الزوجة معتلة الرحم والحيوان المنوي من الزوج ويتم التلقيح، ثم تعاد اللقيحة إلى رحم الزوجة الثانية.

3 **الصورة الثالثة – التبرع بالبويضة:** التبرع بالبويضة من امرأة **أجنبية**، ويُلجأ إليها إذا كانت الزوجة عاقرًا لا يفرز مبيضها بويضات، فيؤخذ البيضة من متبرعة والحيوان المنوي من الزوج ويتم التلقيح، ثم تعاد اللقيحة إلى رحم الزوجة.

4 **الصورة الرابعة – انعدام العلاقات:** تنعدم العلاقات بين أطراف العملية، فتؤخذ البويضة من امرأة أجنبية، والحيوان المنوي من رجل أجنبي، وتوضع بعد تلقيحها في رحم امرأة أجنبية، وبعد الوضع يعطى الجنين لامرأة أخرى أنفقت على العملية. ويُلجأ إليها عند عدم قدرة الزوجين كليًا على الإنجاب.

5 **الصورة الخامسة – بعد وفاة الزوجين:** تؤخذ البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من الزوج، ويتم تلقيحها خارجيًا، ثم تُنقل اللقيحة إلى جسم **متبرعة بالرحم بعد وفاة الزوجين**.

6 **الصورة السادسة – رجل غريب:** تلقح بويضة الزوجة بماء **رجل غريب** ليس زوجها، ثم تُزرع اللقيحة أو الجنين المجمد في رحم امرأة أجنبية، وتُستعمل في حال كون الزوج عقيما والزوجة عندها خلل في رحمها ولكن مبيضها سليم.

⇄ **الصورة السابعة – أنثى حيوان:** تؤخذ بويضة من الزوجة وحيوان منوي من الزوج، ويتم التلقيح خارجيًا، ثم توضع اللقيحة في رحم **أنثى حيوان** يصلح لاحتضان البويضة الملقحة، ثم يعاد الجنين بعدها إلى رحم الزوجة.

✅ **الخلاصة:** وباستقراء الصور يتضح أن الصورتين **الأولى والثانية** هما الأكثر استعمالًا، فأفضل القول في حكمهما، أما باقي الصور فقد وقع **الاتفاق على تحريمها** .

٢ المطلب الثاني: الزرع في رحم الزوجة الأخرى للزوج (الضرة)

هذه الصورة إحدى صور التلقيح الصناعي الخارجي، وفيها يكون للرجل زوجتان أو أكثر، فتؤخذ البويضة من إحداهن والحيوان المنوي من الرجل ثم تزرع في رحم الزوجة الأخرى.

تاريخ القضية في المجمع الفقهي الإسلامي

1. **الدورة السابعة – ١٤٠٤هـ:** عرضت هذه الصورة لأول مرة، وأصدر المجلس قرارًا بـ**جوازها**، إلا أنه مع الاستنكار الشديد اضطر لنظر القضية مرة أخرى.

2. **الدورة الثامنة – ١٤٠٥هـ:** أصدر قراره بـ **التحريم القاطع** .

القولان في المسألة

القول الأول – التحريم: يرى أنصاره تحريم الإخصاب مع استخدام رحم الزوجة الثانية، وهو ما ذهب إليه **أغلب العلماء المعاصرين والمجامع والندوات الفقهية**.

القول الثاني – الجواز: يرى جواز زرع اللقيحة في رحم زوجة أخرى للرجل، وهو قول بعض المعاصرين كالدكتور **عمر الأشقر** والشيخ **محمد علي التسخيري**.

أدلة القول الأول (التحريم)

الدليل الأول – أوصاف الأمومة في القرآن: استدلوا بآيات: «حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ» ، «حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا» ، «يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ» ، «ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ» . فقد بينت هذه الآيات أوصاف الأمومة التي أُنيطت بها الأحكام، ومفادها أن للأمومة وصفين: **وصف التكوين**، و**وصف الحمل والولادة**، فأصل التكوين هي البويضة، وأصل الحمل والولادة هو الرحم، وفي مسألتنا وُجدت الأولى يقينًا وانعدمت الثانية قطعًا، مما يجعل الفعل محرمًا.

NUARA 01105405478

الدليل الثاني – اختلاط الأنساب: إن هذا الفعل يؤدي إلى اختلاط الأنساب من ناحية الأم، إذ قد تحمل الزوجة صاحبة الرحم من زوجها في ذات الوقت، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على هذه الحالة فقال: «*احتمال حمل الزوجة التي زرعت فيها اللقيحة قبل انسداد رحمها على حمل اللقيحة من معاشرة الزوج لها في فترة متقاربة مع زرع اللقيحة ثم تلد توأمين، ولا يُعْلَمُ ولد اللقيحة من ولد معاشرة الزوج... مما يؤدي إلى اختلاط الأنساب من جهة الأم*».

المناقشة : نوقش بمناقشتين: الأولى: إن احتمال حمل صاحب الرحم قبل انسداد الرحم وإن كان واردًا نظريًا إلا أنه مستبعد عمليًا؛ لأن صاحبة الرحم تحتاج إلى فترة إعداد، وغالبًا ما يمنع الاتصال الجنسي في هذه المرحلة. الثانية: إن نقل اللقيحة إلى رحم الزوجة الثانية لا يكون إلا بعد التأكد من خلو رحمها من الحمل، وامتناع الجماع لحين التأكد من حصول الحمل، فلا يترتب اختلاط للأنساب، فيكون مباحًا.

الجواب : هذه الصورة مؤدية إلى اختلاط الأنساب حتى مع منع هذا الاحتمال؛ لأنها تؤدي إلى الاشتباه في تحديد الأم الحقيقية: هل هي صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم.

الدليل الثالث – القياس على السحاق: استدلوا بالقياس على السحاق بجامع أن كليهما وضع لماء امرأة أجنبية في رحم أخرى، ولما كان السحاق محرمًا كان التلقيح محرمًا.

المناقشة : نوقش بأنه قياس مع الفارق: لاختلاف **القصد** (السحاق للمتعة، والتلقيح للاستيلاد)، ولأن السحاق لا ينتج عنه نقل بييضات، ولأن السحاق لا يتضمن الإنزال داخل الفرج بخلاف غرس اللقيحة.

الدليل الرابع – قاعدة تحريم الفروج: استدلوا بالقاعدة: «**الأصل في الفروج التحريم**»، حيث كل أمر يتعلق بالفروج حرام إلا ما ورد الدليل بجوازه، لقوله تعالى: «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ» . فالمباح هو **ماء الزوج** فقط، واللقيحة خليط من ماء الزوج وماء الزوجة، فاجتمع فيها المحظور والمأذون فيه، والقاعدة أن ما اجتمع فيه حظر وإباحة قدّم جانب **الحظر** ، خاصة إذا تعلق بالفروج.

الدليل الخامس – المفاسد العارمة: قرر الفقهاء أن **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**، وفي التبرع بحمل اللقيحة مفاسد تفوق ما فيه من مصالح، إذ تؤدي إلى نزاعات وخلافات، وكل ما أدى إلى النزاع والشقاق كان حرامًا.

المناقشة : يمكن التغلب على هذه الخلافات عن طريق العقد الذي يوضح كل الإجراءات المتفق عليها.

الجواب : هذا من الناحية النظرية، أما عمليًا فالأمر يخالف ذلك؛ لأن **غريزة الأمومة** كفيلة بجعل المرأة تضحي بكل شيء، وشعور المرأتين أن كل واحدة شاركت في تكوين الطفل يجعلها تشعر أنها الأم الحقيقية، مما يؤدي إلى النزاع.

أدلة القول الثاني (الجواز)

الدليل الأول – انعدام اختلاط الأنساب: إن هذه العملية ليس فيها اختلاط للأنساب، ولا مفسدة من مفاسد الزنا.

المناقشة : نوقش بثلاث مناقشات:

- الأولى: عدم اختلاط الأنساب لا يكفي دليلًا للإباحة، بل لا بد من دليل على الحل؛ لأن الزنا ليس الوحيد المحرم من المتعلقات بالفروج.
- الثانية: دعوى عدم اختلاط الأنساب مردودة؛ لأن فيها اختلاطًا من جهة عدم معرفة الأم الحقيقية.
- الثالثة: الفقهاء اتفقوا على تحريم أشياء تتعلق بالفروج مع أنها ليست زنا كالسحاق، مما يدل على أن الأصل في الأبضاع التحريم إلا ما ورد الدليل بحله.

الدليل الثاني – كلتاهما حرث: إن القرآن حدد موضع الحرث في المرأة، وفي مسألتنا كلتا الزوجتين حرث لصاحب النطفة، فلا مانع من حمل إحداهن لقيحة الأخرى.

المناقشة : نوقش بمناقشتين:

- الأولى: ما سبق من أنه عرضة لاختلاط الأنساب.
- الثانية: في حالة تعدد الزوجات يتم كل زواج بعقد مستقل بين رجل وامرأة، أي عقد خالٍ من التثليث، فيجب أن يكون كل حمل ثمرة **اثنين لا مثالثة**، وتظل كلتا الزوجتين خارج نطاق عقد زواج الأخرى.

الرأي الراجح: بعد عرض القولين وأدلتهما يظهر أن الراجح هو القول بـ **تحريم زرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى للزوج** ، وذلك لما يلي:

ا: إن هذه الصورة لا تنطبق عليها شروط الضرورة أو الحاجة؛ لأن الزوجة صاحبة الرحم إذا كانت سليمة المبيض فإن الزوج يمكنه الإنجاب منها مباشرة دون حاجة لبويضة الأخرى، أما لو كانت معتلة المبيض وكلتاهما لا يمكنهما الإنجاب، فمن البدائل المشروعة الزواج بأخرى.

٢: لا يجوز التذرع بتحقيق رغبة المرأة المعتلة المبيض؛ لأن الرغبة الجديرة بالاعتبار هي رغبة من يصلح لأداء دوره الإنجابي، مع أن الرغبة إذا تعارضت مع محظور شرعي فإن اتباع الشرع أولى.

٣: إن حفظ النسل وصيانة الأنساب من **الكليات الخمس** التي جاءت الشريعة لحفظها.

٤: إن القول بالجواز يؤدي إلى نزاعات كثيرة بين أفراد تربطهم علاقات أسرية، وإذا حُسم الخلاف بالقضاء فإن الآثار النفسية تبقى.

٣ المطلب الثالث: استئجار رحم امرأة أجنبية

الأقوال الثلاثة

1. **القول الأول:** **لا تجوز مطلقًا**، لا فرق بين أن تكون صاحبة الرحم البديل زوجة أخرى للرجل أم لا.
2. **القول الثاني:** **جائزة على الإطلاق**، سواء أكانت زوجة أخرى أم لا.
3. **القول الثالث: التفريق**: بينما إذا كانت صاحبة الرحم زوجة أخرى للرجل فيجوز، وإلا فلا.

أدلة القائلين بالحرمة

الدليل الأول – آية حفظ الفروج: قوله تعالى: «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ۝ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ» . وجه الدلالة: حث الله على حفظ الفروج، وبين أن الحفظ لا يكون إلا بقصرها على الزوجة وملك اليمين، والاستثناء يعني أنه لا يجوز إيصال أي شيء إلى امرأة إلا إذا كانت زوجة شرعية. ونقل البويضة الملقحة إلى امرأة أخرى من متعلقات الجماع المحرم، فكأن الرجل اتصل بغير زوجته. وإذا كان قد اتفق على تحريم وضع البويضة المخصبة في رحم زوجة ثانية لنفس الشخص، فمن باب أولى يحرم مع امرأة أجنبية.

الدليل الثاني – الولد من الزوجين: قوله تعالى: «وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً» . وجه الدلالة: بين الله أنه جعل الزوجة من نفس جنس الزوج، ثم أوضح أن الولد إنما يكون من الزوج والزوجة بدليل «*من أزواجكم*»، فهذا نص في عدم جواز تأجير الأرحام؛ لأن الولد لا يكون إلا من زوجة شاركت في إعداده، وصاحبة الرحم البديل ليست كذلك. كما أن الزوجية منتفية بين صاحب الحيوان المنوي وصاحبة البويضة والمرأة المستأجرة.

الدليل الثالث – آية هبة الذكور والإناث: قوله تعالى: «لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ۝ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا» . وجه الدلالة: أخبر الله أنه يهب بمشيئته ويمنع الإنجاب عمن أراد، فدل على أن هناك طائفة ستُصاب بالعقم، فليس هناك مصلحة تتحقق من وراء هذا العمل للمرأة العاقر أو العقيم، فالمؤمن يرضى بأمر الله ويصبر على ما قدره، ولا يجوز مخالفة أحكامه ولا الإتيان بطرق ملتوية تكون مثارًا للشك في الأنساب.

الدليل الرابع – حرمة تأجير الرحم: إن المرأة ليس لها الحق ولا تملك الصلاحية في تأجير رحمها؛ لأن إثبات النسل ووسائل الإنجاب محكومة بنصوص محكمة، كما أن استئجار الرحم يدخل في موضوع الفروج، والأصل في الفروج الحرمة، كما أن هذه العملية تحتوي على استقرار ماء الرجل وزوجته في رحم غريب، وهو غير جائز؛ لأن رحم الأجنبية **محرم** فكانت منفعته محرمة. يقول **ابن رشد**: «*فما اجتمعوا على إبطال إجارته كل منفعة كانت لشيء محرم العين، كذلك كل منفعة كانت محرمة بالشرع مثل أجر النوائح والمغنيات*».

الدليل الخامس – اختلاط الأنساب: إن تأجير الأرحام يؤدي إلى اختلاط الأنساب من ناحية الأم البديلة إذا كانت متزوجة، كما يشتمل على صور من الزنا. ولعل تأجير الأرحام مرفوض للأسباب الآتية:

- ١: إن الجنين إذا وُلِد يعيش في حيرة، فإذا كان نسبه ثابتًا من جهة الأب فالحيرة واقعة من ناحية الأم.
- ٢: إن الجنين الناشئ بهذه الطريقة لا يوجد علميًا ما يقطع بأنه تم تكوينه من الماء والبويضة اللتين تم إدخالهما في الرحم البديل، أو من ماء الرجل وبويضة أنجبتها المرأة نفسها، فيؤدي إلى اختلاط الأنساب، فجاء تحريمه من هذه الناحية، وهو محرم في جميع الملل. لذلك فإن مجمع الفقه الإسلامي في بادئ الأمر عام ١٩٨٦م أباح عملية تأجير الرحم إذا كان الزوج متزوجًا من امرأتين وتقوم إحداهما باستضافة لقيحة الأخرى، ثم عاد وحرم ذلك لأنه يؤدي إلى مفاسد كثيرة.
- ٣: إن النسب نظام اجتماعي وضعه الشارع، وحدد طريقه وهو الزواج الصحيح المستوفي لأركانه وشرائطه.
- ٤: إن مسألة تأجير الأرحام إذا أبيحت فما الذي يضمن أن تقتصر على ذوات الحاجة فقط، فقد تلجأ إليها كل من تريد المحافظة على جمالها ورشاقتها، ومعنى هذا أن المرأة الغنية تستطيع أن تكون أماً لستة وتسعين ولدًا في كل سنة، ويستطيع الرجل الثري أن يكون له جيش من الأولاد بعد أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع.

الدليل السادس – الجدل الأبدي: إن المولود الجديد يولد معه جدل لا يموت إلا بموت صاحبه، فهذه الوسيلة تؤدي في ٩٠٪ من حالاتها إلى مشاكل ونزاعات، والشريعة تمنع كل ما يؤدي إلى النزاع والشقاق. وقد يتفق الطرفان وقد يختلفان، وعند الخلاف قد تعرض الحلول الشعبية ويكون المال كفيلًا بإسكات ذوي الحاجات.

الدليل السابع – المشاكل الأخلاقية والمالية: إباحة هذه الطريقة تتعارض مع الناحية الأخلاقية والاجتماعية، إذ إن العلم مسخر للارتفاع بقيمته الإنسانية وليس العكس، وهناك أسئلة تطرح نفسها:

- هل يمكن أن تكون صاحبة الرحم البديل امرأة مطلقة أو أرملة؟ والجواب بالنفي؛ إذ كيف تعيش بالحمل في بطنها وعليها كل مظاهر الحمل وهي بدون زوج، هل تعلق لافتة تبين أنها صاحبة رحم مؤجر وأن الجنين ليس ابنها؟
- هل يمكن أن تكون زوجة تعيش مع زوجها؟ والجواب أيضًا بالنفي، حتى لو وافق الزوج كتابيًا، فهنا مشاكل دينية وطبية.
- إن تأجير الأرحام يؤدي إلى مشاكل مالية، إذ إن كلمة **التأجير** لا يأتي من ورائها سوى الربح، وهو ما يؤدي إلى جعل ساقطات المجتمع أعلام هذه التجارة، وهو أمر يدعو للاشمئزاز. ونسبة نجاح العملية قليلة وتحتاج إلى إعادتها أكثر من مرة، فالعملية **مكلفة وليست مضمونة**.

القضايا الفعلية التي وصلت إلى المحاكم

1. **قضية ريتا باركر وبولين وهاري تيلر:** عندما وافقت **ريتا باركر** على أن تكون أماً بديلة لزوجين هما «بولين وهاري تيلر» مقابل أجر، وتم الحمل من اللقيحة المكونة من بيضة بولين والحيوان المنوي من هاري، وبدأ هاري يتردد على الأم البديلة فوقعت في حبه وزنا بها، وشعرت الزوجة بالغيرة، ورفضت الأم البديلة تسليم الطفل بعد ولادته بحجة أن مشاعرها تغيرت وصارت تشعر أنها أمه، وتم رفع الأمر إلى القضاء الذي كان في حيرة.

2. **قضية الطفل المُعاق:** حدث عكس ذلك في أمريكا: حيث استأجر زوجان امرأة متزوجة لتكون بديلة مقابل مبلغ، وبعد الولادة تبين أن الطفل معاق ومصاب بنقص بالغ في حجم دماغه، فرفض الزوج الاعتراف به ودفع الأجر، وحكمت المحكمة بإلحاق الولد بالزوج المكتري بناءً على التحاليل، لكن الزوجين رفضا أن يعيش معهما وبقي في دار للحضانة تحملت مصاريفها شركة تأمين.

3 **فضيحة أنجيلا:** نشرت صحيفة «*الجارديان*» فضيحة حول السيدة «**أنجيلا**» التي أجرت رحمها لأسرة غير قادرة على الإنجاب، ولكن الطبيب المختص زرع جنينًا ثانٍ إضافة إلى الجنين المتفق عليه لصالح أسرة أخرى في سبتمبر ١٩٩٦م، وكان الجنينان ينموان طبيعيًا رغم إنكار الأوساط الدينية. وأجاب الطبيب بأن فصيلة دم المولود هي التي ستحدد أبويه الحقيقيين.

أدلة القائلين بالجواز

الدليل الأول – آية القرار المكين: قوله تعالى: «أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ» . وجه الدلالة: يرى المجيزون أن هذه الآيات دليل على أن الجنين نتاج التقاء الحيوان المنوي بالبويضة، ولا دخل للرحم في تكوينه، فالرحم هو الوعاء، وشبهوا دوره بدور الأرض بالنسبة للنبات.

المناقشة : وإن كان الرحم هو الوعاء والقرار، فإن ذلك لا يعني انعدام تأثر الجنين ببعض الصفات من المرأة الحامل؛ لأن الدم وما يقدمه من غذاء وإفرازات وهرمونات يحيط دائمًا بخلايا الجسم ولا بد أن يكون له أثره. كما أن الجنين ليس فقط نتاج الكروموزومات؛ بل هو نتاج العوامل الوراثية وتفاعلها مع البيئة والظروف المحيطة، وأشدها تلك التي يتعرض لها في الرحم. وقد أكد **ابن رشد** هذه الحقيقة بقوله: «*متى صادف المني الهواء فسد مزاجه... في الرحم قوة مغيرة... فالمازج لهذين المنيين والمعطي لهما هذه الصورة هو ضرورة المكون بالحقيقة*».

الدليل الثاني – آيات الأمومة والرضاع: لا تعارض بين قوله تعالى: «إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ» ، وقوله: «وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ» ، وقوله: «حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ» ، وبين إباحة تأجير الأرحام؛ لأن الأم الحقيقية هي صاحبة البويضة، أما صاحبة الرحم فهي **كالأم من الرضاعة** .

الدليل الثالث – الطريق الوحيد: إن إجارة الأرحام تجوز إذا كانت هي الطريق الوحيد للإنجاب وتحقيق رغبة الزوجين، شريطة ألا تكون المرأة متزوجة ولا في حكم المتزوجة، وثبوت القدرة الصحية على إتمام الحمل، وإخطار وليها بذلك.

المناقشة : نوقش بمناقشتين: الأولى: القول بأن التأجير هو الطريق الوحيد لا يصح؛ لأن هناك بدائل أخرى كالزواج من شخص آخر، كما أن اللجوء إلى المحرمات لتحقيق رغبات مباحة ليس إلا اعتراضًا على قضاء الله. الثانية: إن تقييد الإباحة بشروط ليست إلا محاولات لإضفاء الصفة الشرعية عليها، وللشروط في الشريعة أحكام خاصة مضبوطة بضوابط الشرع. ثم إن اشتراط عدم كون المرأة متزوجة شرط بديهي، والقدرة الصحية أمر طبيعي، أما إخطار الولي فهو شرط منتقد؛ إذ لا علاقة للولي بذلك، فقد قرر الفقهاء أن الثيب أحق بنفسها.

الدليل الرابع – العقد: إذا كان من مبررات التحريم ما يؤدي إليه من منازعات، فإنه يمكن التغلب عليها بكتابة عقد تحدد فيه حقوق والتزامات كل طرف.

الدليل الخامس – القياس على الرضاع: استدلوا بالقياس من وجوه:

- قياس الأم صاحبة الرحم على الأم من الرضاع، بجامع أن الله جمع بين الحمل والرضاع في المدة اللازمة لهما في قوله تعالى: «وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا» .
- إن كليهما يتغذى منه الطفل، والأصل المشترك الرحم والثدي.
- وجود العلاقة الطردية بين نمو الثدي للحامل ونمو الجنين.

المناقشة : نوقش بأنه قياس مع الفارق:

- إباحة الاستئجار للرضاع شرعت للضرورة المتمثلة في الحفاظ على حياة الطفل، والضرورات التي تبيح المحظورات تتعلق بهلاك النفس.
- تعليل القياس بالجمع بين الحمل والإرضاع غير مسلم؛ لأن العطف يقتضي المغايرة.
- هناك فارق كبير بين تغذية طفل اكتمل خلقه وانفصل عن أمه، وبين تغذية جنين لم يكتمل خلقه بعد.
- قياس استئجار الرحم على الإرضاع مرفوض لاختلاف تكييف الفعل، فالإرضاع عقد إجارة أباحه الشارع، أما استئجار الرحم فهو فعل لم يُبِحه نص، بل مفهوم النصوص يحرمه؛ لأن التعاقد على محرم لا يجوز.

الدليل السادس – استحالة الاختلاط طبيًا: ثبت طبيًا عدم تحقق الاختلاط بين الأنساب، حيث إن حق الطفل محفوظ عن طريق حمله للصفات الجينية للأب والأم. فيقول علماء الطب: إن البويضة إذا خُصِّبَتْ بماء زوجها ووضعت في رحم امرأة أجنبية لا تتضمن اختلاطًا؛ لأنه في اللحظة التي يتم فيها التلقيح تغرز البويضة الملقحة حاجزًا حولها يمنع المساهمة بأية مواد وراثية أخرى.

الدليل السابع – التداوي: اعتمد المجيزون على أن التأجير يكون من باب **التداوي**، والتداوي مشروع، كما أن عدم قدرة الزوجين على الإنجاب من باب الضرورة التي أقرها الشرع.

المناقشة : يمكن مناقشته بما يلي:

- سلمنا أن عدم القدرة على الإنجاب داء يستوجب الدواء، وأن التداوي مشروع، إلا أن مشروعيته ليست على إطلاقها؛ بل مشروطة بكون الدواء مباحًا، فقد قال النبي ﷺ: «تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ» .
- الاعتماد على قاعدة الضرورة على إطلاقها محل نظر.
- تعارض المصالح: فمصلحة الزوجين خاصة والثانية عامة، وعند التعارض يجب إهمال المصلحة الخاصة.

الرأي الراجح: بعد عرض الأقوال وأدلتها أرى أن تأجير الأرحام **لا يجوز شرعًا** ، لما يلي:

- **١:** إن هذه الوسيلة فضلًا عن كونها ذريعة إلى اختلاط الأنساب نتيجة الازدواج في التكوين والنشأة، فإنها وسيلة إلى الشر والفساد، وكل ما يؤدي إلى الضرر أو الحرام فهو حرام؛ فعادة الشارع ألا يترك المفسدة حتى تقع ثم يعالجها، بل يحتاط في منع الوسائل المؤدية إليها. ولا يقال إن ذلك من باب الضرورات التي تبيح المحظورات؛ لأن ضابط الضرورة خوف الهلاك أو الضرر الشديد على إحدى الضروريات يقينًا أو ظنًا. والأصل: « **دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح** ».
- **٢:** إن القول بالجواز يحول الأمومة من مشاعر مغمورة بالحب والحنان إلى **مهنة تصطبغ بالصبغة التجارية** ، وقد عانى الغرب من ذلك أسوأ معاناة، فبعد انتشار المراكز التجارية صارت المرأة تستأجر، وتحولت الأرحام إلى سوق تجاري للربح المادي.
- **٣:** إننا نعيش في بيئة إسلامية للمرأة فيها وضع خاص يمنع المساس به، فإذا أبيح هذا النوع من الحمل فإنها إما أن تكون متزوجة فمشاكل اختلاط الأنساب لا تنتهي، وإما غير متزوجة فألسنة السوء ستتفوه على المرأة التي حملت من غير زواج. كما أن التطور العلمي لا بد أن يخدم الإنسان، واستئجار الأرحام كشف يؤدي إلى فتح باب الانحلال الخلقي والزنا، ويخالف الفطرة السوية في المجتمعات الإسلامية.

تعد مشكلة نسب طفل استئجار الأرحام من جهة الأم من المشاكل المعقدة التي ثار بشأنها جدل كبير، فبعضهم نظر إلى **أصل التكوين** واعتبر الأم الحقيقية هي صاحبة البويضة، والبعض نظر إلى **الغذاء والحمل والولادة** فاعتبر صاحبة الرحم هي الأم، وبعضهم اعتبر أن للطفل أمين. فالمسألة يتنازعها **ثلاثة أقوال** :

1 النسب من جهة الأم

الأقوال الثلاثة في نسب الطفل من الأم

1. **القول الأول – صاحبة البويضة:** الأم الحقيقية هي **صاحبة البويضة**، وهو ما اختاره مجمع الفقه الإسلامي برأي أكثرية أعضائه وأغلب العلماء المعاصرين.
2. **القول الثاني – صاحبة الرحم:** الطفل ينسب إلى **صاحبة الرحم المؤجر** التي حملت وولدت، فهي أمه الحقيقية، وهو قول بعض العلماء المعاصرين.
3. **القول الثالث – أمّان:** يرى **د. جابر مهران** رأيًا مختلفًا فيقول: «*إني والله سبحانه وتعالى أعلم أرى أن للطفل أمين: الأولى التي حملته، والثانية صاحبة البيضة*». أما الأولى فدليلها ما ذكره القائلون بأن أمه هي من حملته، وإن كانت أدلتهم لا تصلح إلا لإثبات **الأمومة الناقصة** . وأما الثانية صاحبة البيضة فهي أمه أيضًا، لكنها ليست كالأم المرضعة، فليست أمومتها كاملة لأن وصف الولادة لم يتحقق.

أدلة القول الأول (صاحبة البويضة)

الدليل الأول – حديث «الولد للفراش»: قول النبي ﷺ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» . وجه الدلالة:

جعل النبي الفراش علة للحكم بالولد، إذ لا معنى للفراش إلا الزوجية الصحيحة، فالولد في الحديث لا يعني إلا التقاء ماء الرجل مع ماء المرأة.

المناقشة : نوقش بمناقشتين: الأولى: إن هذا الحديث خارج عن محل النزاع، فهو وارد في النسب من جهة الأب، فليس فيه دليل على أحقية صاحبة البويضة بالنسب. الثانية: إن الاستدلال مبني على وجود فراش بين الزوج وصاحبة البويضة، وبالتالي ينسب الطفل إلى صاحبة البويضة وزوجها.

الدليل الثاني – العوامل البيولوجية والوراثية: إن القرآن اهتم بالعوامل البيولوجية والوراثية كأساس لثبوت النسب، حيث ورد أن الأصل في الإنسان النطفة المسماة بالنطفة الأمشاج، حيث تبدأ بالانشطار منذ لحظة التخصيب، حتى يتم تكوين مئات الخلايا، ثم تتطور إلى علقة وتنمو عن طريق امتصاص الغذاء من البرك الدموية الرحمية. وعلى ذلك فالجنين إنما يتكون من الخلايا التي تحمل الصفات الوراثية للأم والأب. يقول **د. عبد المحسن الصالح**: «*فإذا حملت السيدة غير المتزوجة جنينًا غريبًا عنها ووضعته وأرضعته وحضنته، فإن الشعور السائد قد ينسب الطفل إليها على أنها أمه، لكن ذلك ليس صحيحًا من وجهة النظر البيولوجية أو الوراثية... إن السجل الوراثي الحقيقي للوليد قد جاء أساسًا من الخلايا الجنسية للأبوين*».

الدليل الثالث – القياس على نسب الأب: قياس نسب الأم على نسب الأب، إذ إن الأب صاحب النطفة نسب إليه الطفل، فكذلك الأم.

المناقشة : نوقش بأن القياس على نسب الأب قياس مع الفارق؛ لأن النسب الثابت للأب ليس لأن الطفل تخلق من مائه، بل يثبت لأنه **صاحب الفراش** الذي ولد عليه المولود، والغالب في صور التأجير أن يكون صاحب الماء أجنبيًا عن صاحبة الرحم، فلا وجود للفراش، فالقياس غير صحيح.

الجواب : المولود من جهة الأب ينسب إلى صاحب النطفة إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع، فإذا وُجد مانع وهو الزنا انتفى الأصل، إلا أنه لا يلزم من انتفاء النسب عن صاحب النطفة انتفاؤه عن صاحب البويضة، لأن الشارع أثبت نسب المولود من جهة الأم المزني بها، وهو اتفاق العلماء.

الدليل الرابع – القياس على الأنبوب: قياس الرحم المؤجر على أنبوب الاختبار، فالأنبوب ليس له تأثير في النسب، فكذلك الرحم باعتبار أن كليهما وعاء.

المناقشة : قياس رحم المرأة على أنبوب الاختبار مرفوض لثلاثة أسباب:

- إن استخدام الأنبوب لا يؤدي إلى الشك في الأنساب بخلاف رحم المرأة.
- إن الأنبوب ليس إنسانًا يمكن مطالبته بحق أو متطلعًا لذلك الحق.
- إنه يوجد ترابط وتلاحم كاملين بين الجنين وصاحبة الرحم مع إيجاد عاطفة بينهما عكس الأنبوب.

أدلة القول الثاني (صاحبة الرحم)

NARA 01105405478

الدليل الأول – آية الأمومة: قوله تعالى: «إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ» ، وقوله: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ» . وجه الدلالة: دلت الآيتان على أن الأم الحقيقية هي التي حملت وولدت، حيث صرحت الأولى أن الولادة سبب الأمومة، والثانية أسندت أمومة الولد إلى المرأة القائمة بالإرضاع، ومفهوم المخالفة يقتضي انتفاء صفة الأمومة عن التي لم تلد ولم ترضع.

الدليل الثاني – آيات الخلق في البطون: قوله تعالى: «وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ» ، وقوله: «يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ» . وجه الدلالة: بين القرآن أن للخلق أطوارًا تحدث للجنين في رحم الأم، فالأمومة تعتمد على تخلق الجنين في بطن الأم، أما صاحبة البويضة فهذا الوصف غير متحقق فيها.

المناقشة : نوقش بثلاث مناقشات:

- الأولى: إن مفهوم الأمومة في هذه الآيات يقتضي أن الأم هي التي تحمل المولود في رحمها بعد اختلاط مائها بماء زوجها، فهي تشارك في تكوين المولود، وتقوم بحمله حتى تضعه.
- الثانية: إن حصر الأم في المرأة التي تحمل وتلد يتعارض مع قوله تعالى: «وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ» ، لأن الله سماها أما.
- الثالثة: إن حصر الأم في التي تحمل وتلد ليس مقصودًا هنا، لأن للآية سببًا خاصًا، حيث نزلت ردًا على الذين يشبهون زوجاتهم بأمهاتهم (الظهار).

الجواب : بجوابين:

- الأول: سلمنا أن الآية نزلت في بيان أمر الظهار، إلا أن ذلك لا يعتبر دليلًا على نفي حصر الأمومة في الولادة.
- الثاني: لا نسلم أن حصر الأمومة في الولادة يخرج الأم من الرضاعة لوجود الفارق الكبير بينهما، فتسميتها أما لترتب بعض الأحكام الشرعية على الرضاعة.

الدليل الثالث – الغذاء والآلام: إن الغذاء الذي نما به الطفل في بطن الأم إنما كان من دم المرأة صاحبة الرحم، كما أنها هي التي تحملت آلام الحمل والولادة وأوجاعهما، فكان منطقيًا أن تكون هي الأم، على عكس صاحبة البويضة التي لم تذق هذه الآلام.

MARA 01105405478

الدليل الرابع – قياس الدجاجة الحاضنة: استدلوا بقياس صاحبة البويضة على الدجاجة التي تبيض البيض ولا تحضنه، فالفرخ الناتج ينسب إلى الحاضنة لا إلى صاحبة البويضة.

المناقشة : نوقش من وجهين:

- الأول: إن القياس منقوض بما لو كان البيض الذي تحضنه الدجاجة بيضًا لطيور أخرى كالبط والحمام، فقطعًا أن البطة أو الحمامة لا تنسب إلى الدجاجة.
- الثاني: إن الشارع لم يرتب على أنساب الحيوانات أحكامًا شرعية، ولذا لم يشترط شروطًا للإنجاب بين الحيوانات بخلاف الإنسان، فهو الفارق.

الرأي الراجح في نسب الأم: من خلال ما تقدم يترجح عندي قول من قال بأن الأم الحقيقية هي **صاحبة البويضة** ، وذلك لما يلي:

- **١**: إن هذا القول هو ما تطمئن إليه النفوس نظرًا لاتفاقه مع **الفطرة السوية**.
- **٢**: إن الأدلة التي استدل بها أنصار هذا القول **قوية في الدلالة** على أن صاحبة البويضة هي الأم الحقيقية.
- **٣**: إن المعتبر في نظر الشرع هو لحظة تلقيح البويضة، فما دام التلقيح تم بين بويضة الزوجة والحيوان المنوي من الزوج فإن صفة الاحترام وجدت في الماءين، وبالتالي يثبت النسب لهما، أي أن نسب الطفل قد ثبت لصاحبة البويضة قبل أن تدخل اللقيحة في الرحم الآخر، واستمر هذا النسب ثابتًا طيلة وجود اللقيحة في الرحم.

٢ النسب من جهة الأب

اختلف العلماء في نسب الطفل من ناحية الأب، فبعض الفقهاء اعتبر أن الأب هو **صاحب النطفة**، في حين ذهب البعض الآخر إلى أن النسب **لصاحب الفراش** أي زوج المرأة التي غرست اللقيحة في رحمها، وإذا كانت ليست بذات زوج أخذ هذا الولد حكم ابن الزنا.

الرأي الراجح: ولكن بعيدًا عن الخلاف السابق أرى أنه في ظل التطورات العلمية والتقدم الطبي، فإن النسب يثبت **لصاحب الحيوان المنوي** حيث تتخذ مجموعة من الإجراءات التي تكفل اتخاذ الحيطة والحذر لضمان سلامة هذه العملية من أية شوائب، إذ يمنع الاتصال الجنسي بين صاحبة الرحم وزوجها طيلة الفترة الأولية المخصصة لإجراء العملية، لذا فإن الطفل ينسب إلى الرجل صاحب الحيوان المنوي.

تدريبات: على الوحدة الثانية

١ بين المفهوم العلمي والشرعي لعملية تأجير الأرحام.

٢ تأجير الأرحام يأخذ صورًا عديدة، اذكرها على سبيل الإجمال.

٣ اذكر دليلين من أدلة القائلين بجواز تأجير الأرحام، ثم قم بمناقشتها والرد عليها.

٤ لمن ينسب طفل تأجير الأرحام من جهة الأم؟

٥ متى يكون تأجير الأرحام جائزًا؟

MNARA 01105405478

القضية الثالثة: موت الدماغ وجدال فقهي حول نزع الأجهزة ونقل الأعضاء وهل يعد موتًا حقيقيًا؟

١ المفهوم الشرعي والطبي للموت

٢ التكييف الشرعي لموت الدماغ

٣ حكم الاستفادة من أعضاء موتى الدماغ

تمهيد: نشأة القضية وموقعها من النوازل الطبية

قضية الحياة والموت تشغل بال الإنسان دائمًا، بل إن فلسفة الموت تأخذ حيزًا من التفكير أكبر من فلسفة الحياة؛ لأن الإنسان إذا وُلد وترعرع فإن الموت في انتظاره. وقد كثرت المفاهيم التي تنازعت معنى الموت، وكشف الأطباء عن صور حديثة كـ**موت الدماغ**، وصرح أغلبهم بأنه موت بالمعنى الحقيقي، إلا أن هذا الاتجاه وجد معارضة من بعض الأطباء وأغلب علماء الشريعة؛ لأن للموت عندهم علامات لا بد من تحققها.

فالمشكلة إذن هي عدم التوافق بين المفهوم الشرعي والمفهوم الطبي، مما أثار تساؤلًا: هل يمكن الوصول إلى مفهوم توافقي؟ أضف إلى ذلك أن الخلاف يأخذنا إلى خلاف أكثر خطورة وهو تحديد لحظة الوفاة، إذ يترتب عليها أحكام: متى تبدأ عدة الزوجة؟ وهل يتحقق الإرث؟ وهل يجوز الحصول على الأعضاء؟ وقد نظمت الحديث في مقدمة وثلاثة مباحث.

⚠ **ملاحظة جوهرية:** ورغم أن هذا المفهوم الجديد لموت الدماغ قد تبنته كثير من الدول الغربية فإن مشاكله لا حدود لها، ووصلت إلى المحاكم؛ لأنه **يتنافى مع الفطرة السوية** ، وفيه اعتراض على مشيئة الله باللجوء إلى وسائل مثيرة للشك في الأنساب، وفق قرارات المجامع الفقهية.

المبحث الأول: مفهوم موت الدماغ

١ المطلب الأول: تعريف الموت

أ- الموت في اللغة

الموت والحياة في لغة العرب متناقضان، فتُعَرَّف كل واحدة منهما بأنها نقيض الأخرى. وأصل الموت في لغة العرب **السكون**، وكل ما سكن فقد مات، تقول العرب: ماتت النار إذا برد رمادها، وماتت الريح إذا ركدت. قال ابن فارس: «*الميم والواو والتاء أصل صحيح يدل على ذهاب القوة من الشيء.*»

معاني الموت في القرآن الكريم – معنيان

1. **المعنى الأول: إزالة القوة الحية النامية:** كقوله تعالى: «لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا»
2. **المعنى الثاني: زوال القوة الحساسة:** كقوله ﷻ: «أَئِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا»

ب- الموت في الاصطلاح

الموت عند جمهور أهل السنة **صفة وجودية مضادة للحياة**، وقالت المعتزلة: هو عدم الحياة عما شأنه، ويرون أن المراد بالخلق في قوله: «الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ» هو التقدير.

المذهب	التعريف الاصطلاحي
الحنفية	صفة وجودية مضادة للحياة، وقيل: عدم الحياة.
المالكية	الوفاة هي مفارقة الروح للجسد.
الشافعية	الموت مفارقة الروح الجسد.
الحنابلة	لم يعرفوا الموت اكتفاءً بذكر علاماته.

دلالة النصوص: وبناءً على ما سبق فإن الموت الذي يصيب الإنسان هو **موت نسبي**، أي موت بالنسبة لعلم البشر في حدود تكليفهم، فهو موت جزئي يقتصر على مفارقة الحياة الدنيا، ولا يمتد إلى حياة البرزخ. قال القرطبي في تفسير قوله: «وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا» : «*وأجل الموت هو الوقت الذي في معلومه سبحانه أن روح الحي تفارق جسده.*»

التعريف الطبي للموت

وقد ذكر الأطباء للموت تعريفات، أهمها: هو **التوقف النهائي لكل مظاهر الحياة** أو التفاعلات الحيوية بالجسم مع وجود بعض مظاهر الحياة بالأنسجة والخلايا. وعُرِّفَ أيضًا بأنه: **انقطاع الحياة** نتيجة توقف واحد أو أكثر من أجهزته الحيوية عن العمل.

النتائج المستخلصة من التعريفات

1. **النتيجة الأولى:** إن الموت مخلوق كالحياة فليس فناءً محضًا.
2. **النتيجة الثانية:** إن الله ذكر الموت أولًا قبل الحياة، وهذا الترتيب ينبيء عن الترتيب الطبيعي بينهما، فالتغير عبارة عن موت مرحلة وبداية أخرى.
3. **النتيجة الثالثة:** إن الحكمة من خلق الموت والحياة هي **الابتلاء والاختبار**، وهذا يجب أن يُحَوّل خوف الفرد من الموت كفناء إلى خوف تربوي له أثره في السلوك.
4. **النتيجة الرابعة:** إن تعريفات الفقهاء اقتصرت على الإشارة إلى العلاقة بين الروح والجسد، دون تفصيلات، وهذه التفصيلات صار لها أهمية كبيرة في ظل التطورات الطبية.

ج- صعوبة وضع تعريف جامع للموت

الموت هو نهاية الحياة الإنسانية، قال تعالى: «كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ» إلا أن المسألة التي أثارت انتباه العلماء هي **تحديد اللحظة التي يحكم فيها بموت الإنسان**. ففي الماضي كان الأمر سهلاً، إذ بمجرد خروج الروح وظهور علامات الموت يحكم بالموت، أما في العصر الحاضر مع انتشار أجهزة الإنعاش وظهور مصطلحات كالموت الإكلينيكي وموت الدماغ، صار من الصعب تحديد لحظة الوفاة، ومما يزيد الصعوبة **خلوها من النص** الذي يبين حكمها، بخلاف مسألة بداية الحياة حيث وردت الأحاديث التي تبين بدايتها.

قاعدتان في ظل غياب النص: **القاعدة الأولى**: إن الأمر بين تحديد البدء والانتهاء ينبغي أن يكون عكسيًا، فإذا كانت البداية هي تعلق الروح بالبدن، فالمنطق أن تنتهي الحياة بانقطاع هذا التعلق.

القاعدة الثانية: إن الروح خلق من خلق الله يمكن للإنسان البحث فيه من حيث خصائصه وأنشطته وآثاره.

فالقاعدة الأولى نتيجة منطقية تنطلق من **قاعدة السببية**، وبما أن الله جعل لبداية الحياة سببًا هو تعلق الروح بالجسد، فإن النهاية حتمًا تكون بالافتراق. وإذا كان علماء الإسلام لم يحددوا اللحظة التي تتم فيها المفارقة فإنهم أكدوا أن ملازمة الروح للجسد مرهونة بصلاحية هذا الجسد لخدمة الروح، وبالتالي إذا صار الجسد عاجزًا عن خدمة الروح كان ذلك سببًا داعيًا للافتراق.

٢ المطلب الثاني: تعريف موت الدماغ وطرق تشخيصه

هناك تناقض واضح في تحديد المفهوم العلمي لموت الدماغ، حيث يختلف تعريفه من بلد لآخر، بل في البلد الواحد، نظرًا لاختلاف المعايير. ويقرر الأطباء أن المريض في غرفة الإنعاش لا يخلو من إحدى ثلاث صور:

1. **الصورة الأولى:** عودة أجهزة المريض من التنفس وانتظام ضربات القلب، فيقرر الطبيب رفع أجهزة الإنعاش.
2. **الصورة الثانية:** التوقف التام للقلب والتنفس وعدم القابلية لآلة الطبيب، فيقرر الطبيب موت المريض تمامًا.
3. **الصورة الثالثة:** قيام علامات موت الدماغ من الإغماء وعدم الحركة وعدم النشاط الكهربائي في رسم المخ، لكن بواسطة العناية المركزة، ولا يزال القلب ينبض والنفس مستمر. وفي هذه الحالة يقرر الطبيب موت المريض بموت جذع الدماغ.

أولًا: مفهوم موت الدماغ

عُرف موت الدماغ بتعريفات متعددة، أهمها:

1. **التعريف الأول:** «**تلف دائم في الدماغ يؤدي إلى توقف دائم لجميع وظائفه**، بما فيها وظائف جذع الدماغ.»
2. **التعريف الثاني:** غياب الأداء السريري للدماغ غيابًا لا يقبل الانعكاس، بما في ذلك جذع الدماغ.

الطب الشرعي وتغيرات ما بعد الموت: ويقرر الطب الشرعي أن حالات الموت تحدث فيها ثلاثة عوامل: **توقف الدورة الدموية، توقف التنفس، توقف الجهاز العصبي ونشاط الدماغ.** ومع ذلك هناك متغيرات تحدث تدريجيًا بالموت: التلون الموتى، برودة الجسم، التيبس الموتى، التحلل الموتى. والتيبس يبدأ في العضلات الصغيرة حول الفك ثم يمتد تدريجيًا، ويحدث في فترة

تتراوح بين ساعتين واثنتي عشرة ساعة، ويحدث التحلل خلال أربع وعشرين ساعة. ومن الطبيعي أنه إذا لم تحدث تغيرات ما بعد الموت فإن هذا الجسد ما يزال حيًا، ولذلك فإن الرأي الطبي السليم يقرر أنه إذا لم نستطع أن نقطع بزوال علامات الحياة فإننا لا نحكم بالموت إلا بعد ظهور تغيرات ما بعد الموت.

ثانيًا: أسباب موت الدماغ

السبب الأول – حوادث المرور: إصابات الدماغ بسبب الحوادث وأهمها حوادث المرور، وتمثل ٥٠٪ من جميع حالات موت الدماغ.

السبب الثاني – النزف الداخلي: نزف داخلي بالدماغ بمختلف أسبابه، ويمثل حوالي ٢٠٪.

السبب الثالث – الأورام والالتهابات: أورام الدماغ والتهابات الدماغ وخراج الدماغ والسحايا، وتمثل حوالي ٢٠٪.

ثالثًا: أهمية التشخيص المبكر لموت الدماغ وطرقه

يلجأ الأطباء في تشخيص الموت إلى إحدى طريقتين:

الطريقة الأولى – التشخيص السلبي: البحث عن مظاهر الحياة للتأكد من زوالها (التشخيص السلبي للموت)، وتثبت فور حدوث الموت.

الطريقة الثانية – التشخيص الإيجابي: البحث عن علامات التغيرات التي تصيب الجسد بعد الموت (التشخيص الإيجابي للموت)، ولا تثبت إلا بعد مرور ساعات.

معايير تشخيص موت الدماغ: ١: غيبوبة عميقة مع انعدام الإدراك والاستجابة.

٢: العلامات السريرية لتوقف وظائف جذع الدماغ، وتشمل غياب منعكسات الحدقة والقرنية، والمنعكس الرأسي العيني، والمنعكس العيني الدهليزي البلعومي، ومنعكس السعال والتقيؤ.

٣: انعدام قدرة المصاب على التنفس التلقائي، بالاختبار المتعمد أثناء توقف مضخة التنفس لفترة محدودة (ثلاث أو أربع دقائق، أو عشر دقائق حسب المدارس).

٤: عدم وجود حركة الدمية عند تحريك الرأس، وإعادة فحص وظائف الدماغ من فريق آخر بعد مرور عدة ساعات.

٥: لا يعتبر رسم الدماغ أساسيًا في تشخيص موت الدماغ، إلا أنه قد يكون دليلًا إضافيًا مفيدًا من الناحية القانونية.

MNARA 01105405478

والغالب أن تشخيص موت الدماغ يعد عملاً سريريًا بالدرجة الأولى، إلا أن الطبيب في سبيل التأكد يلجأ إلى مجموعة من الاختبارات المساعدة، وتكون أمامه أربع خيارات: الانتظار لمدة اثنتي عشرة ساعة، أو سكون كهرباء قشرة الدماغ، أو إلغاء إمكانات جذع الدماغ السمعية المثارة، أو إظهار مؤقت دورة الدم داخل المخ. وقد وُضِعَتْ معايير منها: **معايير هارفارد**، و**معايير مينيسوتا**، و**معايير الجمعية الطبية الكندية**.

المبحث الثاني: التكييف الشرعي لموت الدماغ

تعد مسألة موت الدماغ من نوازل العصر التي تتطلب حكمًا شرعيًا، والتكييف الشرعي أحد أمرين: إما القول بأنه **يعتبر موتًا** فتترتب عليه جميع آثار الموت، وإما القول بعدم اعتباره موتًا فلا يتم إعلان الوفاة.

تحرير محل النزاع

1. **موضع الاتفاق الأول:** اتفق الفقهاء والأطباء على أن الموت في الأحوال العادية يتحقق بمجرد مفارقة الروح للجسد وتوقف القلب والنبض والتنفس.
2. **موضع الاتفاق الثاني:** اتفقوا على أن الغيبوبة وتوقف الدماغ لا يحكم بالموت بناءً عليهما، فحالات الغيبوبة المؤقتة والسكتة الدماغية لا تعتبر موتًا.
3. **موضع الاختلاف:** اختلفوا فيما إذا تم تشخيص المريض على أنه ميت دماغيًا وفق الأصول الطبية، إلا أن قلبه لا يزال ينبض ويتنفس عن طريق الأجهزة، فهل بموت دماغه فقط يعتبر ميتًا؟ وقد اختلفوا على رأيين:

⊘ **الرأي الأول – موت الدماغ لا يعتبر موتًا حقيقيًا:** لا بد من توقف عمل جميع أعضاء الجسم.

وهو ما ذهب إليه بعض الأطباء وكثير من الفقهاء المعاصرين منهم: د. بكر أبو زيد، والشيخ جاد الحق علي جاد الحق، والشيخ بدر المتولي عبد الباسط، والدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور محمد سعيد البوطي، والدكتور محمد الشنقيطي، وهو ما أخذ به المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، ولجنة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية.

✔ **الرأي الثاني – موت الدماغ يعتبر موتًا حقيقيًا:** تترتب عليه أحكام الموت. وهو رأي أغلب الأطباء وبعض الفقهاء المعاصرين وبعض القانونيين، وهو ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي الدولي في مؤتمره الثالث في عمان عام ١٤٠٧هـ.

١ الدليل الأول: من الكتاب – آيات أصحاب الكهف

استدلوا بآيات أصحاب الكهف: «أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ۝ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝ فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۝ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ»

وجه الدلالة: أصحاب الكهف طيلة هذه المدة لم يكونوا في عداد الأموات؛ بدليل أن الله لم يصفهم بالموت، بل أفقدهم القدرة فقط بدلالة قوله: «فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ» والضرب على الآذان هو المنع من الاستماع، فكان دليلاً على أنهم لم يموتوا. يقول الدكتور توفيق الواعي: أجمع الفقهاء والمفسرون على أن كلمة «بعثناهم» معناها أيقظناهم، لأن أجسامهم كانت حية.

المناقشة: نوقش بأنه مبني على أن موت الدماغ هو زوال الشعور والإحساس، وهو أمر لم يقل به أحد؛ بل هو تعطيل لمركز الأوامر الحياتية، والأطباء مجمعون على أنه لا أمل في إعادة حياة من ثبت تشخيص موت دماغه. أضف إلى ذلك أن ما حدث مع أصحاب الكهف ليس موتًا بل نوم عادي طالت مدته.

الجواب: لم نقل إن موت الدماغ هو زوال الشعور والإحساس، بل وجه الشبه بينهما هو **بقاء الأعضاء حية**، فكما أن أصحاب الكهف أحياء لبقاء صفة الحياة في الأعضاء، فكذلك الميت دماغيًا.

٢ الدليل الثاني: من السنة – حديث المرأة التي ضربت ضرتها

استدلوا بحديث المرأة التي ضربت ضرتها فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي ﷺ بغرة عبد أو وليدة، فقال أخوها: «أنغرم من لا أكل ولا شرب ولا نطر ولا استهل؟» فقال ﷺ: «أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ» . وحديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها فقتلت ولدها، فقضى بدية ما في بطنها

غرة عبد أو أمة، فقال ولي المرأة: «كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟» فقال ﷺ: ««إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ»» .

وجه الدلالة: قضاء النبي ﷺ بالدية يدل بمفهوم المخالفة على اشتراط **موت جميع الأعضاء** للحكم بالموت؛ حيث أثبت الحياة له لثبوت حياة بعض الأعضاء، والميت دماغيًا ما زالت الحياة سارية في بعض أعضائه، بل إن هناك تشابهًا بين الجنين والميت دماغيًا في أمارات الحياة الظاهرة: التنفس والنبض واستمرار النمو.

٣ الدليل الثالث: علامات الموت عند الفقهاء

إن الفقهاء عند بيانهم لحقيقة الموت حددوا علامات لإصدار الحكم بالموت، وهي: **استرخاء القدمين، اعوجاج المنخر، انخساف الصدغين، امتداد جلدة الوجه، تدلي جلدة الخصية.** وقد اعتبر النبي ﷺ هذه العلامات وحكم بقرب الموت بناءً عليها، فقد أخرج أبو داود عن الحصين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي ﷺ يعوده فقال: ««إِنِّي لَأَرَى طَلْحَةَ إِلَّا قَدْ حَدَثَ فِيهِ الْمَوْتُ، فَآذِنُونِي بِهِ وَعَجِّلُوا، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ»» . والعلامات التي ذكرها الفقهاء تعني موت جميع الأعضاء، لذا فإن موت الدماغ لا يعتبر موتًا بالمعنى المعروف لدى الفقهاء.

٤ الدليل الرابع: قاعدة سد الذرائع

ويتحقق إعمالها من عدة وجوه:

1. **الوجه الأول:** الاعتراف بهذا المفهوم يتيح أجسادًا للبحث العلمي أقرب ما تكون إلى الحياة، وهذا يعني أن هذه الأجساد ليست ميتة، الأمر الذي يكون عائقًا أمام التقدم، إذ إن احتمال إيجاد دواء لمرضى موت الدماغ ليس بالمستحيل. وقال أحد الأطباء: «إن التغيرات الوظيفية تخضع لمحاولات العلاج حتى في الوقت الحالي، وأن العلاج الدوائي في المستقبل قد يظهر أن جذع المخ الذي انعدمت وظائفه لم يدمر بطريقة لا يمكن إصلاحها؛ ولكن فقط تعطل تعطلاً مؤقتًا.»
2. **الوجه الثاني:** إن قبول التعريف الجديد قد يكون عاملاً في فقدان الجمهور الثقة في الأطباء؛ لأن المعلوم أن الأطباء رحمة من الله، فإذا تحولوا إلى مجرد المتاجرة بالأجساد كان لذلك أضراره.

3 **الوجه الثالث:** إن تعريف الموت بناءً على مفهوم غامض أدى إلى ظهور معايير مختلفة من بلد لآخر، بل من مستشفى لآخر، فيصبح المرء ميتًا في إحدى المستشفيات، فإذا انتقل إلى مستشفى آخر صار حيًا، وهذا يعكس عدم مصداقية المفهوم.

٥ الدليل الخامس: الاستصحاب

معناه بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد المزيل. والحياة ثابتة والموت مختلف في حدوثه ومشكوك فيه، فينبغي الحكم بالحياة حتى يقوم الدليل على انتهائها.

المناقشة: الحياة وإن كانت ثابتة باعتبارها الأصل، فإن الموت قد طرأ وقامت عليه الأدلة مما ذكره الأطباء بعد الفحص واستخدام أجهزة رسم المخ.

الجواب: الأدلة التي ذكرها المجيزون لا تنهض من حيث قوتها على إثبات العكس، حيث تبناها المجيزون من الأطباء في حين رفضها البعض الآخر، فالدليل الطارئ ليس في قوة الدليل الأصلي.

٦ الدليل السادس: علامات الحياة في الميت دماغيًا

إن الأشخاص الذين يتم تشخيصهم كموتى دماغيًا تتوافر فيهم علامات الحياة: استمرار الأفعال المنعكسة من سعال وقيء، وجود النشاط العصبي العضلي والارتعاشات العضلية، الاستجابة المنعكسة في النشاط الدموي، المحافظة على حرارة الجسم، استمرار نمو الأظافر والشعر، واستمرار الحمل لدى الحوامل. يقول الدكتور أحمد الشواربي: «*إنه من الثابت في كل المراجع الطبية أن حالات موت المخ يكون أصحابها أحياء، تظهر فيهم مظاهر الحياة المختلفة... وإن هذه الدلائل كلها تقطع باستمرار الحياة في هذه الأجساد، ومن ثم فإن تدخل الطبيب بإنهاء حياة هؤلاء إنما هو قتل النفس التي حرم الله قتلها.*»

المناقشة: نوقش بمناقشتين: **الأولى**: إن وجود هذه الانعكاسات لا يعني نفي موت الدماغ، وله شبيه في الطب كالميت الذي يتحرك بمجرد تعرض الجثة للصعق الكهربائي. **الثانية**: إن بقاء عضو من الأعضاء على قيد الحياة لا يتعارض مع موت صاحبه، فالقلب يمكن أن يستمر في العمل خارج الجسد.

الجواب: استمرار عمل الأجهزة المختلفة كالقلب والكبد والكليتين وإفراز الهرمونات والاحتفاظ بدرجة الحرارة كلها أدلة قاطعة على الاستمرار في الحياة، وفرنسا لم تحكم على هذا

الشخص بأنه ميت بل أسمته «**الميت الحي**»، وقالوا إنه ميت حسب الوجهة القانونية لأنه فقد الاتصال بالآخرين.

٧ الدليل السابع: استمرار النبض والدورة الدموية

إن المحكوم عليه بالموت بناءً على موت الدماغ لا يزال قلبه ينبض ودورته الدموية تعمل، وهذا أعظم دليل على استقرار الحياة في الجسد. وهناك اتفاق بين علماء الشرع والطب على أن الروح متصلة بالجسد اتصالاً وثيقاً، وأن علامة مفارقة الروح للجسد هي موت الدماغ بصورة نهائية، وأن حياة الخلايا الجسدية تميز حياة الروح. يقول الدكتور توفيق الواعي: «*إن تعطل الإنسان لا يدل على فقد الحياة، اللهم إلا إذا كان على سبيل المجاز أو التشبيه، فلا يقول عاقل أن النائم ميت، ولا أن المجنون فاقد للحياة.*»

٨ الدليل الثامن: عدم قبول الاعتماد على رسم المخ

إن الاعتماد على جهاز رسم المخ للوصول إلى اليقين أمر غير مقبول؛ لأن الوقائع تكذب نتائج هذا الجهاز، ومن هذه العلامات: الكحة والاستعداد للقيء عند إدخال شيء في الفم، النشاط العضلي والعصبي، ثني الذراعين ومحاولة القيام، تغير النبض وضغط الدم أثناء عملية نزع الأعضاء.

٩ الدليل التاسع: اختلاف القائلين بموت الدماغ

إن القائلين بفكرة موت الدماغ اختلفوا فيما إذا كان موت المخ موتًا لسائر الجسم، فيقترح «جايلين» أن يطلق على الشخص الذي مات مخه اسم «**الميت الجديد**» ليميز بين الجسم الذي يتنفس صناعيًا عن الجسم الميت موتًا حقيقيًا. وفي مجال إجراء البحوث على مرضى موت الدماغ اعترف الباحثون أن الميت الجديد يشبه الشخص الحي أكثر من شبهه بالشخص الميت.

١٠ الدليل العاشر: قواعد قابلة للعكس

إن الأطباء يقررون أن وفاة الإنسان تتحقق بتوقف خلايا المخ عن أداء وظيفتها، إلا أن هذه القواعد قابلة لإثبات العكس بالكشف عن علاجات في المستقبل، فهناك أمراض مات بسببها الكثيرون ثم اكتُشفت لها العلاجات، وقد كان توقف القلب سببًا للوفاة ثم اكتُشفت وسائل إنعاش القلب.

١١ الدليل الحادي عشر: فترة الاحتضار

أقر الأطباء أن هناك فترة لا تقل عن أربع دقائق بين توقف القلب والتنفس وبين تشخيص الموت الإكلينيكي، وخلال هذه الفترة تكون أغلب الأعضاء حية، وخلايا المخ حية، ولو تم إسعاف الشخص فمن الممكن أن يعود إلى وعيه. وهذه الفترة تسمى **فترة الاحتضار**، والمحتضر لا يوصف بأنه ميت.

١٢ الدليل الثاني عشر: الموت والحياة لا يجتمعان

إن الموت حقيقة وجودية خلقت ضد الحياة، والموت والحياة لا يجتمعان في بدن واحد، ومرضى الغيبوبة الدماغية إما أن يوصفوا بالموت أو الحياة، ووصفهم بأنهم أموات منقوض باستمرار مظاهر الحياة. والحياة البدنية هي المعتبرة وليست الحياة الإدراكية، لأنها مناط التكليف ولكن انتهائها بالغيبوبة لا يعني موت صاحبها.

١٣ الدليل الثالث عشر: عدم اعتراف بعض الدول

لا زال من الأطباء والدول من لا يعترف بأن الشخص الذي حدث له موت الدماغ يعامل كميت، فمع أن القوانين في معظم الدول تعتبره ميتًا، فإن معظم دول العالم الثالث وبعض الدول الإسلامية والصين لا تعترف بذلك، فلا تعترف بالموت إلا إذا توقف القلب والتنبض. واليابان لا تعترف بالموت إلا إذا ماتت جميع أعضاء الإنسان.

١٤ الدليل الرابع عشر: مفارقة الروح للجسد

إن الموت الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية لا يتحقق إلا بمفارقة الروح للجسد مفارقة تامة، وهذا ما دلت عليه عبارات الفقهاء، وبالثورة الهائلة في المجال الطبي أكد الطب أنه من الممكن التأكد من موت الدماغ بجهاز رسم المخ، إلا أن هذا لم يصل إلى مرتبة الحقيقة العلمية المستقرة، فلا يجوز اعتماد هذه الظاهرة وحدها.

١٥ الدليل الخامس عشر: حفظ النفس والاحتياط

أمر الإسلام بحفظ النفس، ومن مقتضيات حفظ النفس الاحتياط والانتظار قبل الحكم بالموت، إذ لا ينبغي أن يتم الحكم إلا بتوافر الأدلة القاطعة. قال في المغني: «*وَإِنْ اشْتَبَهَ أَمْرُ الْمَيِّتِ، اعْتُبِرَ بِظُهُورِ أَمَارَاتِ الْمَوْتِ... وَإِنْ مَاتَ فَجْأَةً كَالْمَصْعُوقِ... أَنْتَظِرُ بِهِ هَذِهِ الْعَلَامَاتُ*

حَتَّى يُتَيَقَّنَ مَوْتُهُ.» وقال النووي: «*يستحب المبادرة إلى غسله إذا تحقق موته، فإن شك... أخر إلى اليقين.*»

المناقشة: نوقش بأن العلامات التي ذكرها الفقهاء ليست قطعية، فالله قادر على أن يعيد الحياة بعد ظهورها، لذا كان الاعتماد على ما ذكره الأطباء أولى.

الجواب: الله أناط الحكم بموت الإنسان بالعلامات مع الاحتياط في الحالات الاستثنائية، أما موت الدماغ وحده دون سائر العلامات فالعهدة فيه على الذين اجتهدوا وقاسوا، وهو قياس مع الفارق.

أدلة الرأي الثاني (اعتبار موت الدماغ موتًا حقيقيًا)

١ الدليل الأول: حديث أم سلمة

ما روي عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله ﷺ على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: «««إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ»» . وجه الدلالة: أفاد أن الروح إذا فارقت البدن تبعها البصر، فلا يبقى أي منعكس من منعكسات العين، وهذا هو حقيقة موت الدماغ.

المناقشة: استدلال أخرج الحديث عما يرمي إليه، فالعلماء قرروا أنه يحتمل أمرين: **الأول**: أن ذلك يكون بعد خروج الروح من أكثر البدن وهي لا تزال باقية في الرأس والعين. **الثاني**: أن يحمل على أن الروح لها اتصال بالبدن وإن كانت خارجة. فالحديث خارج عن محل النزاع.

٢ الدليل الثاني: الروح والجسد

إن العلماء قرروا أن الإنسان روح وجسد، وأن علامة الحياة هي ملازمة الروح للجسد حتى يقوم بخدمة الروح، وإذا أصبح الجسد عاجزًا عن خدمة الروح كان ذلك نهاية لحياة الشخص، وموتى الدماغ تتحقق فيهم تلك الأوصاف. يقول الغزالي: «*معنى مفارقة الروح للجسد انقطاع تصرفها عن الجسد بخروج الجسد عن طاعتها... والموت عبارة عن استعصاء الأعضاء كلها.*» ويقول ابن القيم: «*الروح جسم نوراني... فما دامت الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها بقي ذلك الجسم مشابكًا لها، وإذا فسدت الأعضاء فارق الروح البدن.*»

المناقشة: نسلم أن الجسد خادم للروح، وأن عجزه عن خدمتها إيذان بنهاية الحياة، ولكن لا نسلم باليقين بأنه في حالة موت الدماغ يتحقق عجز الجسد عن خدمة الروح، ثم إن المقصود

بالعجز هو **العجز الكلي** المتمثل في عدم القدرة الحالية وعدم إمكانية ذلك مستقبلاً، وهذا ما لا يمكن القطع به، بدليل خرق بعض الحالات لتلك القواعد.

٣ الدليل الثالث: عدم تجدد خلايا المخ

إن من مات مخه لا يمكن أن يعود للحياة، إذ من المبادئ الأساسية أن خلايا المخ لا تتجدد في حالة تلفها، فوجود أعضاء الجسم حية بعد موت المخ لا يعني أنها ستستمر طويلاً، لأن جميع الأعضاء تعمل تحت سيطرة المخ، فبمجرد موت المخ تبدأ الأعضاء في التحلل التدريجي.

❓ **المناقشة:** نوقش بمناقشتين: **الأولى**: إن التسليم بذلك يفتح بابًا واسعًا من الاعتداءات، إذ يترتب عليه أن المجنون يجوز التصرف في جسده، وهذا المفهوم يواجه معارضة كبيرة، إذ وفقًا له يجوز الحكم بالموت على كل مرضى الغيبوبة العميقة ومصابي الأمراض العقلية. **الثانية**: إن هذا الاستدلال منقوض بوجود حالات تم تشخيصها كموت دماغ ثم عادت للحياة.

↩ **الجواب:** الحالات التي أُفيقت فوق ندرتها لم يتم تشخيصها في البداية تشخيصًا صحيحًا، كما أن الخلط بين الغيبوبة الطويلة وموت الدماغ خلط بين الحياة والموت.

٤ الدليل الرابع: عبارات الفقهاء

إن عبارات الفقهاء القدامى تؤكد أن الشخص لا يطلق عليه أنه ميت إلا إذا انعدمت فيه كل مظاهر الحياة. قال الزركشي في المنثور: «*وَالْحَيَاةُ الْمُسْتَقِرَّةُ هِيَ أَنْ تَكُونَ الرُّوحُ فِي الْجَسَدِ وَمَعَهَا الْحَرَكَةُ الاخْتِيَارِيَّةُ دُونَ الاضْطِرَارِيَّةِ*.»

❓ **المناقشة:** الفقهاء لم يحكموا بموت الشخص إذا كانت حياته غير مستقرة، وإنما لم يوجبوا القصاص على من طعن من أبينت حشوته، لأن فعله ليس هو المؤثر في موته. ومما يؤكد ذلك أن الفقهاء ذكروا أن المجني عليه إذا صار إلى مرحلة الحياة غير المستقرة بسبب مرض أو فعل حيوان مفترس فأجهز عليه مجرم، فإن جمهور الفقهاء يذهبون إلى إيجاب القصاص.

٥ الدليل الخامس: النسيج الشبكي وإعلان سيدني

أثبتت المصادر الطبية أن **النسيج الشبكي** هو المسئول عن وعي الإنسان، وليس هناك أمل في إيجاد بديل للمخ في المستقبل. وقد جاء في إعلان سيدني ١٩٦٨م: «*إن الموت على مستوى الخلية أو الأنسجة عملية تدريجية... وليس المهم تحديد موت الأعضاء المختلفة،*

وإنما المهم التأكد من أن عملية الموت قد وصلت إلى نقطة لا يمكن عندها وقفها... وإن وجد عضو أو مجموعة من الخلايا حية فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن الكائن ذاته حي.»

٦ الدليل السادس: اختصاص الأطباء

إن مسألة تحديد نهاية الحياة من اختصاص الأطباء، فهم الذين يقفون على الثغرة الحرجة، وملازمة الروح للجسد مرهونة بصلاحية الجسد لخدمة الروح، والعلم هو الذي يستطيع أن يعرف تلك اللحظة.

المناقشة: الحكم على شخص بالموت أو بعدمه مسألة شرعية قبل كونها طبية، إذ يترتب عليها أحكام شرعية. ولو سلمنا أنها اختصاص الأطباء، فالأطباء أنفسهم مختلفون، مضافًا إلى الأخطاء التي قد تحدث في التشخيص.

٧ الدليل السابع: الفوائد المادية والمعنوية

إن القول باعتبار موت الدماغ موتًا حقيقيًا يؤدي إلى فوائد مادية ومعنوية، منها: اهتمام فريق نقل الأعضاء، توفير التكاليف الباهظة، توفير سرير في العناية المركزة، التقليل من الفترة المحزنة للأقارب، منع الإساءة إلى المتوفي، رفع أجهزة الإنعاش، إزالة الإحباط لدى العاملين، البدء في ترتيب أوضاع المستحقين للإرث.

المناقشة: يمكن مناقشته بما يلي:

١: الفوائد المادية لا يمكن أن تكون من العوامل المؤثرة في تحديد الحكم الشرعي.

٢: القول بتقليل الفترة المحزنة غير مقبول؛ فإذا كان الأقارب يحزنون على بقاء مريضهم تحت الأجهزة، فإن الحزن سيزداد في حالة علمهم أن أعضاءه أخذت لينتفع بها غيره.

٣: الادعاء بأن العاملين يصابون بإحباط غير منطقي؛ لأن التسليم بذلك يعني إنهاء حياة المريض الميؤوس من شفائه كمرضى الإيدز والسرطان.

٤: هذا القول يتعارض مع الهدف من مهنة الطب؛ فالطبيب يقوم بعلاج المريض مهما ساءت حالته.

٨ الدليل الثامن: شيوع العمل بمعيار موت الدماغ

إن تحديد الوفاة بموت الدماغ ساد العمل به في معظم البلدان المتقدمة، وحقيقة الموت واحدة للإنسان، ويجب ألا تختلف باختلاف البلدان، وقد وُضِعت علامات واضحة للوفاة الدماغية، وأن جميع من ماتوا لتوافر شروط التشخيص فيهم لم يرجعوا للحياة مرة أخرى.

ففي مراجع الطب وجد عدد **١٠٣٦ حالة موت دماغي** نشرت في ستة عشر تقريرًا بين عامي ١٩٦٨-١٩٨٨ جميعها توقفت قلوبهم بالرغم من الاستمرار في علاجهم.

المناقشة: فيه نوع من التناقض؛ إذ أفاد أن حقيقة الموت واحدة، وهذا مقبول، ولكن الثابت أن القواعد التي يتم بها التشخيص تختلف من بلد لآخر. كما أن القول بأن كل من تم تشخيصهم لم يرجع منهم أحد مردود بثبوت رجوع بعضهم للحياة.

٩ الدليل التاسع: موت القلب وموت جذع الدماغ

إن موت القلب لا يعد موتًا نهائيًا؛ وإنما الموت النهائي هو **موت جذع الدماغ**، والدليل أن عملية زرع القلب بعد استئصال القلب الأصلي لا تعد موتًا، وكذا من أخذ القلب منه فإن قلبه لا يزال حيًا مع أن صاحبه قد مات.

المناقشة: خارج عن محل النزاع؛ فمحل النزاع موت الدماغ وليس موت القلب، والخلاف في وفاة الإنسان شرعًا بعد موت دماغه وقبل توقف القلب والتنفس اللذان يعملان بالآلة.

١٠ الدليل العاشر: قول اللخمي والمواق

استدلوا بقول اللخمي: اختلف في الحركة والرضاع والعطاس، فقال مالك: لا يكون له بذلك حكم الحياة. وعقب المواق بقوله: «*فقد كان عمر رضي الله عنه لما طعن معدودًا في الأموات، لو مات له موروث لما ورثه... ولو قتل رجل عمر حينئذ لما قتل به، وإن كان عمر حينئذ يتكلم ويعهد.*» فقد دلت النصوص على أن الحياة لا تثبت إلا بالصوت، والصوت حركة مرتبطة بالدماغ، فإذا كان الدماغ هامدًا لا يعطي أوامره فإنه لا حياة.

١١ الدليل الحادي عشر: بقاء الأعضاء حية

من المتعارف عليه طبيًا أن بعض أعضاء الجسد قد تبقى حية بعد موت صاحبه دماغيًا، ومن أوضح الأمثلة ما يحدث للمحكوم عليهم بالإعدام شنقًا، فبمجرد الشنق تنقطع الدورة الدموية عن الدماغ، بينما يستمر القلب في ضخ الدم لعدة دقائق قد تصل إلى ١٥ أو ٢٠ دقيقة، الأمر الذي يؤكد وجود فترة زمنية بين موت القلب وموت الإنسان، وهذه الفترة يمكن التحكم في إطالتها باستخدام أجهزة الإنعاش.

الرأي الراجح

بعد عرض الآراء وأدلتها يتضح أن المسألة من المسائل الشائكة. فالأطباء يرون في عجز الأعضاء عن خدمة الروح موتًا محققًا، والفقهاء يرون الجسد والروح شيئًا واحدًا، ويعتبرون أن بقاء عضو حيًا دليلًا على حياة صاحبه.

الرأي الراجح: أرى أن الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول (**عدم اعتبار موت الدماغ موتًا حقيقيًا**)، وذلك لما يلي:

١: قوة الأدلة التي اعتمد عليها هذا القول، وضعف أدلة المخالف.

٢: إن أدلة الرأي المخالف تقوم على قواعد علمية تم إثبات عكسها في بعض الحالات، وهذه الحالات وإن كانت نادرة إلا أنها تضع علامة استفهام، لأن الأمر يتعلق بالأرواح.

٣: إن القول باعتبار موت الدماغ موتًا حقيقيًا يخالف المنطق، بل يؤدي إلى قتل الأبرياء، حيث إن الأطباء في الماضي كانوا يرون أن المعول عليه توقف القلب، ثم وجدت أساليب إنعاش القلب، ثم نجدهم الآن يقررون أن موت الدماغ هو الفيصل، ومن المنطقي أن يتم استحداث منعشات للدماغ في المستقبل كما تم للقلب.

٤: إن معنى الموت الذي يعلمه العامة هو عدم صلاحية الجسد لأن يحدث به أي مظهر من مظاهر الحياة، وهذا يختلف مع ما يسمى بموت الدماغ، حيث إن الأطباء أنفسهم قرروا أن الميت دماغيًا تظل له بعض مظاهر الحياة كنمو شعره وأظافره، وقد نُقل أن امرأة من فنلندا دخلت في غيبوبة طويلة وتم التقرير بموت دماغها وكانت حاملاً وولدت طفلها أثناء الغيبوبة ثم عادت للحياة بعد ذلك.

٥: إن هناك تناقضًا واضحًا، مفاده أن القائلين بموت الدماغ أطلقوا عليه اسم « **الميت الحي** » واتفقوا على حياة بعض أعضائه، فهل يجتمع الموت والحياة في جسد واحد؟ هذا أمر محال، فعلماء اللغة يعرفون الموت والحياة بأن كلًا منهما نقيض الآخر.

٦: إن الأطباء عندما تكلموا عن موت الدماغ يرددون عبارة «توقف لا أمل في رجوعه» أي ميؤوس من شفائه، وأنا أتساءل: هل الميؤوس من شفائه شخص حي أم ميت؟ هو بالمنطق يعد حيًا؛ لأنهم يطلقون عليه مريض، والمريض لا يمكن أن يكون ميتًا.

المبحث الثالث: حكم الاستفادة من أعضاء موتى الدماغ

شاع لدى الكثيرين أن الهدف الرئيس من إقرار ما يسمى بموت الدماغ هو إيجاد مبرر للحصول على أعضاء هؤلاء الأشخاص في حالة جيدة. وهذه المسألة ترتكز على ثلاثة محاور: **الطبي**، و**الشرعي والقانوني**، و**الأخلاقي**، وبينها ارتباط لا يقبل التجزئة؛ لأن الأطباء المسلمين لن يقوموا بهذا العمل إلا إذا توفر لهم الغطاء الشرعي والقانوني.

تحرير محل النزاع

1. **موضع الاتفاق الأول:** لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز نقل الأعضاء إذا ترتب على هذا النقل ضرر، سواء بالمنقول منه أم المنقول إليه.

2. **موضع الاتفاق الثاني:** لا خلاف على حرمة نقل الأعضاء إذا تم بمقابل، حتى لا يكون جسم الإنسان محلاً للاتجار. قال ابن الهمام: «*لا يجوز بيع أجزاء الإنسان، ولا الانتفاع بها، لأن الآدمي مكرم لا يبتذل، فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهانًا.*»

3. **موضع الاختلاف:** مع اتفاق الفقهاء على ما تقدم اختلفوا في الاستفادة بأعضاء موتى الدماغ عن طريق استئصالها وزرعها للغير على رأيين:

⊘ **الرأي الأول – عدم جواز استقطاع أعضاء موتى الدماغ:** ذهب إليه العلماء والأطباء القائلون بعدم اعتبار موت الدماغ موتًا حقيقيًا، وكذلك الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والزيدية، والشيخ محمد متولي الشعراوي، والدكتور محمد رأفت عثمان، بناءً على أن الميت دماغيًا يعتبر حيًا، ونقل الأعضاء بين الأحياء لا يجوز.

✓ **الرأي الثاني – جواز استقطاع الأعضاء من موتى الدماغ:** ذهب إليه القائلون باعتبار موت الدماغ موتًا حقيقيًا، وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في قرارها رقم ٩٩ الصادر في ٦/١١/١٤٠٢هـ، حيث قرر المجلس بالإجماع جواز نقل عضو من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعت الحاجة وأمن الخطر، كما قرر بالأكثرية جواز نقل عضو من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك وأمنت الفتنة وغلب على الظن نجاح الزرع، وجواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه إلى مسلم مضطر.

أدلة الرأي الأول (عدم الجواز)

١ الدليل الأول: حديث جابر

ما روي عن جابر أن النبي ﷺ قال في قصة الرجل الذي قطع براجمه فشخبت يداه حتى مات: «اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ» . وجه الدلالة: إن النبي ﷺ توعد من أقدم على إهلاك نفسه؛ لأن الإنسان لا يملك أن يفسد من نفسه شيئًا، وفي نقل الأعضاء إفساد بالنفس، كما أن النبي ﷺ طلب المغفرة لمن يقوم بذلك، فكان دليلاً على أنه ارتكب إثمًا. والميت دماغيًا فاقد للقدرة على التعبير عن إرادته، فالتصرف في أعضائه لا يجوز.

٢ الدليل الثاني: حديث عائشة

ما روي عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ».

وجه الدلالة: أثبت الحديث **معصومية الجسد** سواءً أكان حيًا أم ميتًا، وساوى بينهما في العقوبة. قال الشوكاني: «*فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الرِّفْقِ بِالْمَيِّتِ... وَإِنْ كَانَ فِي الْإِثْمِ فَلَا شَكَّ فِي التَّحْرِيمِ.*»

٣ الدليل الثالث: نصوص الفقهاء

- **النص الأول:** ما جاء في بلغة السالك: «*فإن بقي شيء من عظامه، فالحرمة باقية لجميعه، فلا يجوز استخدام ظفر الميت ولا جزء منه ولا شعره، لأن هذه الأجزاء محترمة، وفي أخذها انتهاك لحرمتها.*»
- **النص الثاني:** قال ابن قدامة في المغني: «*فإن لم يجد المضطر شيئًا لم يبح له أكل بعض أعضائه... وإن وجد معصومًا ميتًا لم يبح أكله.*»

وجه الدلالة: دلت النصوص على عدم جواز نقل الأعضاء، إذ أفادت عدم جواز استخدام ظفر الميت ولا شعره، ويقاس عليه سائر الأعضاء. والإنسان في حالة الاضطرار لا يجوز له أن يأكل بعضه ليحيى به نفسه، فمن باب أولى لا يجوز له أن يعطي عضوه ليحيى غيره. والميت دماغيًا ما زال على قيد الحياة وفقًا لما رجحناه، فينطبق عليه الحكم.

٤ الدليل الرابع: الشك في بقاء الحياة

إن مسألة الحكم على الميت دماغيًا فيها شيء من الشك، وما دام هناك احتمال ولو ضئيل في بقاء هذا الشخص على قيد الحياة، فلا يجوز استقطاع أعضائه، إذ بهذا الفعل يصبح الموت مصيره المحتوم.

٥ الدليل الخامس: الإيلام والتعذيب

إن عملية نقل العضو فيها نوع من الإيلام والتعذيب، لا سيما وأنه تم التقرير بأن الميت دماغيًا ما زالت فيه بعض مظاهر الحياة من حس وحركة ونبض.

المناقشة: نوقش بأمرين: **الأول**: الدعوى بوجود الألم لا محل لها؛ لأن تلك العمليات لا تتم إلا بعد تخدير كامل، كما أن الألم له أهداف إنسانية، فالغاية تبرر الوسيلة. **الثاني**: الإيلام المحرم

هو المقصود لذاته، أما إذا كان الغرض مشروعًا فصاحبته بعض الآلام فلا حرج، كالعمليات الجراحية والختان.

الجواب: قولكم بعدم وجود الألم بعد تخدير المريض كليًا محل نظر؛ لأن الميت دماغيًا من وجهة نظركم ميت، فلماذا التخدير إذن؟ ومن ناحية أخرى ذكرت المراجع الطبية أن مثل هذا النوع من العمليات لا يتم فيه تخدير، حيث ذكرت أن بعض المرضى لما هم الأطباء بنزع الأعضاء شعر بالألم وزادت حركته فأوقف الأطباء عملهم.

٦ الدليل السادس: نشاط أوعية القلب

من المتعارف عليه طبيًا أن نشاط أوعية القلب الدموية بالنسبة لمن يسمون بموتى الدماغ ما زال يعمل بصورة طبيعية، وبالتالي فإن نزع الأعضاء يتطلب تشريعًا. يقول د. ديفيد ج. هيل: *«ألم يحن الوقت كي نمنح المرضى على الأقل الحماية ذاتها التي نصر على منحها للحيوان، وأن نستخدم المعايير ذاتها القاضية بضرورة التوقف الدائم للدورة الدموية أو تدمير الدماغ لكي نقرر أن الموت قد حدث فعلاً قبل أن نشرع في إزالة الأعضاء الحيوية.»* ويقول الدكتور صفوت لطفي: *«إذا كان الله تعالى قد أمر بعدم قطع شيء من البهيمة قبل أن تموت تمامًا... فأولى بذلك أن نتحرج من التصرف في الإنسان الذي كرمه الله حيًا وميتًا.»*

٧ الدليل السابع: تعارض مع الرسالة السامية للأطباء

إن استقطاع الأعضاء من موتى الدماغ يتعارض مع الرسالة السامية للأطباء؛ لأن الأخلاق الطبية توجب التحقق الذي يصل إلى مرتبة **اليقين** من موت الإنسان بجميع أعضائه، وليس الموت الجزئي. لذلك أفتى مجمع البحوث الإسلامية في مصر بأن من يقوم بالانتزاع من جسد لم يزل قلبه نابضًا بالحياة ولم تزل فيه بقية من حياة فهو قاتل نفسًا حرم الله قتلها إلا بالحق.

٨ الدليل الثامن: عائق أمام إيجاد العلاج

إن القول بجواز استقطاع الأعضاء يقف عائقًا أمام إيجاد علاج لبعض الأمراض المستعصية؛ حيث يعتمد الأطباء على أن الميت دماغيًا ستتم الاستفادة منه، بدلاً من التكاتف لإيجاد سبب من أسباب الفشل. وقد ظهرت دلائل نجاح في التجارب على **الخلايا الجذعية**، إضافة إلى التجارب على محاليل تُحقن في جسد المتوفى عند الوفاة مباشرة تعمل على أن تظل أعضاؤه صالحة للنقل لفترات زمنية.

٩ الدليل التاسع: من المعقول

1. **الوجه الأول:** إن حرمة المال أقل من حرمة النفس، وقد أمر النبي ﷺ بتوقي كرائم أموال الناس، فمن باب أولى أن تتقى أعضاؤهم.
2. **الوجه الثاني:** لا يجوز استقطاع الأعضاء الآدمية من موتى الدماغ؛ لأنهم أحياء، قياسًا على عدم جواز استقطاع الأبضاع، بجامع كون كل منهما من أعضاء الجسد.

أدلة الرأي الثاني (الجواز)

١ الدليل الأول: عموم أدلة الضرورة

عموم الأدلة التي تقضي بجواز نقل الأعضاء للتداوي، ومنها قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٧٣]. وجه الدلالة: حالة الضرورة مستثناة من الحكم العام، والمريض إذا احتاج إلى نقل العضو يكون داخلًا في حكم المضطر؛ لأن حياته مهددة، والمنقول منه – الميت دماغيًا – يعد ميتًا وفقًا للمعايير الطبية.

المناقشة: الاستدلال بقاعدة الضرورة محل نظر؛ لأنه لا علاقة للآية بنقل أعضاء الميت، بل وردت في ما يحل وما يحرم من المأكل والمشرب، وإذا كان الله قد بين المحرمات على سبيل التفصيل وأباح ما يجوز عند الضرورة، فيجب الاقتصار على ما ورد. أضف إلى ذلك أن نظرية الضرورة لا تقبل في جرائم النفس؛ إذ لا يصلح أن ينقذ إنسان على حساب إنسان آخر، وهو أمر محل إجماع.

٢ الدليل الثاني: قول الدكتور محمد سيد طنطاوي

ما نقل عن الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق: «*وإن كان بعض العلماء يرى أن جسد الإنسان ملك لله... إلا أنني أخالفه الرأي في الجزء المتعلق بالتبرع لأنه لا بأس به إذا رأى الأطباء أنه سيفيد المتبرع له أكثر من ضرره للمتبرع... وإن التبرع جائز عند جمهور الفقهاء، ولا فرق بين تبرع الأقارب أو غيرهم، مادام يؤكد نفعه الأطباء الثقات.*»

٣ الدليل الثالث: الصدقة الجارية

إن بقاء الأعضاء الآدمية لشخص آخر ينتفع بها بعد موت صاحبه يعتبر من قبيل **الصدقة الجارية** المأمور بها في حديث: «إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ

جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»» . وبهذا تكون صدقة مندوبًا إليها، خاصةً إذا أوصى صاحبها بذلك قبل الوفاة.

المناقشة: نوقش الدليلان بما يلي:

١: الصدقة الجارية لها حدودها المأذون فيها شرعًا، فالإيثار شرع في حدود قدرة الشخص، أي في الحظوظ الدنيوية، فأعضاء الجسم ليست محلاً للإيثار.

٢: قضية تبرع الإنسان بأعضائه ليست محل اعتبار هنا، لأن من أركان التبرع أن يكون المتبرع مالكًا للشيء، والمالك للجسد هو الله عز وجل ولا ولاية للإنسان عليه إلا في الحدود المرسومة من قبل الشرع.

٤ الدليل الرابع: تفريج الكربات

إن في نقل الأعضاء تفريجًا للكربات وتأكيدًا على مبدأ التراحم، قال تعالى: «وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ» [الحشر: ٩]، وقال النبي ﷺ: ««مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ»» . وتفريج الكربات كما يكون بالمال يكون بغيره، فالمعروف عام يدخل فيه سائر أنواع البر، فيدخل فيه التبرع ببعض البدن لمنفعة الغير، والبدن أفضل من المال.

٥ الدليل الخامس: إتلاف الجزء لإبقاء الكل

إن هناك من فقهاء المذهب الشافعي من أباح للمضطر أن يقطع جزءًا من جسده ليسد به رمقه إذا خاف على نفسه الهلاك، فللمضطر أن يتلف الجزء لإبقاء الكل، لأن الضرر الأكبر يدفع بالضرر الأدنى. والمريض هنا كالمضطر فيجوز أن يتبرع شخص له بجزء من جسده، ما دام لا يلحق به الضرر، ولا يؤدي إلى عجزه أو تشويهه، وكان النقل مفيدًا في غالب ظن الطبيب المسلم، شريطة أن يتم ذلك دون الحصول على أي مقابل مالي.

٦ الدليل السادس: القياس

١ **القياس الأول:** القياس على جواز نقل الأعضاء بين الأحياء، فإذا جاز للإنسان التبرع بأعضائه حال الحياة فلا مانع من أن يوصي بذلك بعد موته.

2 **القياس الثاني:** القياس على التشريح، فإذا كان التشريح أجازه الفقهاء لأغراض محددة، فإن نقل بعض الأعضاء للغير يكون جائزًا.

3 **القياس الثالث:** القياس على التبرع بالدم، إذ الدم جزء من الجسم، وكذلك يجوز للمرأة أن تتبرع بلبنها لترضع طفلًا لامرأة أخرى، فتبرع الإنسان بجزء من جسمه أمر جائز بشروط وضوابط ما دام في ذلك منفعة للغير وليس فيه مضرة للمتبرع.

الرأي الراجح

أرى أن الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول القاضي بـ **حرمة استقطاع أعضاء موتى الدماغ** ، وذلك للأسباب الآتية:

1 **السبب الأول:** قوة الأدلة التي استند إليها أنصار هذا الرأي، وخلوها عن المعارض الذي يقدح في صحتها من الناحيتين الشرعية والطبية.

2 **السبب الثاني:** إن المجيزين أسسوا رأيهم على اعتبار موتى الدماغ أمواتًا بالمعنى الحقيقي، في حين أن الاتجاه القوي من الفقهاء والأطباء رفضوا هذا المفهوم، وفي تقديري أن لفظ الاستحالة في الطب والجزم بعدم عودة مريض للحياة أمر مستبعد، حيث إن الله قادر على إنعاش المريض مرة أخرى بعد فقدان الأمل، والتاريخ الطبي بوقائعه أكبر شاهد.

3 **السبب الثالث:** إن عمليات نقل الأعضاء لا تخلو من أضرار تلحق بالمنقول إليه وتجعله عرضة للإصابة بأمراض خطيرة، منها: الأورام السرطانية، حيث وجد أن نسبة الأورام في المرضى الذين تم زراعة كلى لهم تزيد مائة مرة عن النسب المعتادة، وأهمها سرطان الجلد وسرطان العقد الليمفاوية وورم كابوسي. كما تشمل المضاعفات النزيف الدموي والجلطات في الأوردة والشرايين وارتفاع ضغط الدم.

4 **السبب الرابع:** إن الهدف الرئيس من إثارة الأطباء لهذه المسألة هو الحصول على الغطاء الشرعي الذي يسمح لهم بممارسة هذه الأعمال والاعتداء على أجساد المرضى تحقيقًا لمطامع الشهرة والثراء.

5 **السبب الخامس:** إن الأصل الذي جاءت به الشريعة هو المحافظة على النفوس وليس القضاء عليها، لذا فإن الأطباء يقدمون على هذا الفعل لعلمهم أن أعضاء المريض في هذه المرحلة تكون صالحة للاستعمال، أما بعد الموت الذي يعني موت جميع الأعضاء فتفقد تلك الأعضاء هذه الصلاحية، لذلك يحرصون على جني الأعضاء في تلك الفترة، أي أنهم يتعجلون، والقاعدة أن من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه.

تدريبات: على الوحدة الثالثة

١ حدد المفهوم الشرعي للموت، مقارنًا بينه وبين المفهوم العلمي.

٢ ما هو ضابط الموت الذي وضعه الفقهاء، وهل يتماشى مع ما ذهب إليه الأطباء؟

٣ القول باعتبار موت الدماغ موتًا حقيقيًا يترتب عليه مفاسد كبيرة، اشرح هذه العبارة.

٤ هل يجوز نقل أعضاء موتى الدماغ؟ بين الآراء على سبيل الإجمال، مع ذكر الراجح.

٥ حدد المفهوم العلمي لموت الدماغ كما وضعه الأطباء، ثم بين مدى انطباقه على المفهوم الشرعي.

MARA 01105405478

MNARA

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

السلسلة الأكاديمية الشاملة – مقررات الفرقة الأولى

دليل مذكرات السلسلة المعتمدة

★ **القضايا الفقهية المعاصرة** — هذا المقرر الحالي

- علم الإجرام والعقاب — متاح بالتطبيق
- مصطلح الحديث — متاح بالتطبيق
- تاريخ التشريع — متاح بالتطبيق
- تاريخ القانون — متاح بالتطبيق

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الأولى

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478